FRONT

en

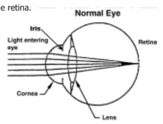
PATIENT INFORMATION LEAFLET

Device Type: Intraocular Lens (Phakic)

Introduction
This patient information leaflet is designed to help you decide whether you want to have an Implantable Phakic Contact Lens (IPCL V2.0) placed in one or both eyes to correct your nearsightedness (myopia) or farsightedness (hyperopia). It is important to understand the benefits and possible risks before making your decision. Please read this leaflet carefully and discuss any questions with a doctor trained in IPCL V2.0 surgery.

What Is Nearsightedness and farsightedness?

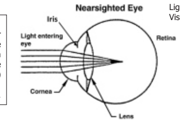
NORMAL EYE
Light focuses on the retina.
Vision is clear.



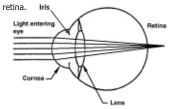
NORMAL EYE:
Your eye works like a camera. You see objects because your eye focuses light into images. Both the clear front layer of your eye, called the cornea, and your natural crystalline lens focuses rays of light onto the back surface of the eye, called the retina.

NEARSIGHTED EYE
Light focuses in front of the retina.
Vision is blurry.

NEARSIGHTED EYE:
Nearsightedness is a focusing error that causes blurrier vision at distance than at near. Light from an object in the distance focuses in front of the back surface of your eye (retina) responsible for capturing images, rather than directly on the retina.



FARSIGHTED EYE
Light Focuses behind the retina.
Vision is blurry

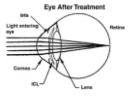


FARSIGHTED EYE:
Farsightedness (hyperopia) is a common vision condition in which you can see distant objects clearly, but objects nearby may be blurry.

Glasses and contact lenses can help your eye focus light properly on the retina. The IPCL V2.0 can also help your eye focus light properly on the retina.

How Does IPCL V2.0 Correct Nearsightedness and farsightedness?

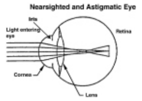
CORRECTION OF VISION AFTER IPCL V2.0 SURGERY



A diopter (D) is a unit used to measure how well your eye can focus. It shows the level of nearsightedness, farsightedness, or astigmatism you have. IPCL V2.0 surgery can treat nearsightedness from -0.5 D to -15.0 D and farsightedness from +0.5 D to +15.0 D. If your vision falls within these ranges, this surgery may help you see clearly without glasses or contact lenses.

The IPCL V2.0 monofocal lens does not correct astigmatism. Astigmatism is a common vision problem that causes blurred or uneven vision. It happens when the front surface of the eye (cornea) is not evenly shaped. Because of this, light does not focus properly inside the eye, and some parts of what you see may look clearer than others.

NEARSIGHTED and ASTIGMATIC EYE



IPCL V2.0 Toric / IPCL V2.0 Presbyopic Toric can correct any astigmatism you have upto +1.0 D to +10D. You are requested to consult your doctors to choose appropriate suitable options for your eye.

Choosing the best lens for your vision
There are different types of lenses available. Your eye doctor will help you choose the one that is best for you. Other treatment options include glasses with thick lenses or contact lenses instead of a permanent lens implant. Talk to your eye doctor about the benefits and possible risks of each option

Other Treatments to Correct Nearsightedness and Farsightedness ?
Other treatments to correct nearsightedness and farsightedness include eyeglasses, contact lenses, and refractive surgical procedures. Surgical options include Photorefractive Keratectomy (PRK), Laser-Assisted in Situ Keratomileusis (LASIK), refractive lens exchange (RLE), and phakic intraocular lens implantation (e.g., IPCL V2.0). However, these procedures may not meet the visual requirements for certain professions, such as military service.

These procedures either reshape the cornea or place a lens inside the eye. PRK and LASIK use a laser to change the shape of the cornea so the eye can focus better. In LASIK, a thin flap of the cornea is lifted, the laser reshapes the tissue underneath, and the flap is put back in place to heal. Phakic intraocular lens implantation, like IPCL V2.0, adds an artificial lens inside the eye without removing your natural lens.

Benefit And Risks of the IPCL v2.0
IPCL V2.0 surgery can safely correct nearsightedness between –0.5D to –15D and farsightedness between +0.5D to +15D. If your eyeglass prescription is in these ranges, the IPCL V2.0 may make your distance vision without eyeglasses or contact lens correction better.
Implanting IPCL V2.0 requires eye surgery, which carries potential risks. Please read this leaflet carefully and talk to your doctor about the possible risks.

■ **Few of the risks are as below**

- Additional surgery

Sometimes, a second surgery may be needed to remove, replace, or adjust the IPCL V2.0. It may need to be removed during cataract surgery. Additional surgery might also be needed to reduce eye pressure.

- Cataract formation

After Phakic IOL surgery, there is an increased risk that the natural lens of your eye may become cloudy, leading to cataracts that could require surgery. The longer the IPCL V2.0 stays in the eye, the higher this risk becomes. Regular eye exams are important to check for cataracts. Older patients and those with stronger nearsightedness or farsightedness may have a higher risk. The long-term risk beyond 7 years is not known. If cataract surgery is needed, the IPCL V2.0 and the cloudy lens are removed, and a new lens is implanted, just like routine cataract surgery.

- Loss of Best Corrected Vision (BCVA)

The most common reason was clouding of the natural lens (cataract). Vision may get better in these eyes after cataract surgery.

- Raised pressure inside the eye and damage to the optical nerve caused by increased pressure in eye (Glaucoma)

Normal eye pressure (intraocular pressure or IOP) can vary but is often considered to be from 10-21 millimeters of mercury (mmHg). An IOP higher than normal is called ocular hypertension and if left untreated, can cause damage to the optic nerve (glaucoma) and cause permanent vision loss.

- **Endothelial Cell Loss**

The cornea (the clear front part of your eye) has a thin layer of special cells called endothelial cells. These cells keep the cornea clear by removing extra fluid. Normally, the number of these cells slowly decreases with age. Eye surgery, including IPCL V2.0, can cause additional loss of these cells. If too many cells are lost, the cornea can become cloudy and affect your vision. Before surgery, your doctor will examine your eyes to check if you are suitable for IPCL V2.0. After the surgery, some ongoing loss of these cells may occur over time. If too many cells are lost, fluid can build up in the cornea (called corneal edema), which may require a cornea transplant.

■ **Other Complications**
Other risks associated with IPCL V2.0 surgery may include:
- movement of the colored portion of the eye (iris) through a surgical wound to a position outside the eye (iris prolapse),
- bleeding in the area on the retina responsible for reading vision (macular hemorrhage),
- bleeding under the retina (subretinal hemorrhage),
- increase in focusing error (astigmatism),
- lifting or pulling of the retina from its natural position (retinal detachment),
- unequal pupil size (anisocoria).

Adverse reactions and complications due to, or following surgery and implication of any implantable Phakic Contact Lens may include, but are not limited to:

- Increased astigmatism
- Refractive error
- Intraocular infection
- Vitreous loss
- Vaulting issue
- Anterior subcapsular cataract
- Severe intraocular inflammation
- Glaucoma
- Secondary glaucoma
- Uveitis
- Vitritis
- Hyphema
- Hypopyon
- Under/over correction
- Non-reactive pupil
- Endophthalmitis
- TASS
- Retinal Detachment
- Iritis
- Cystoid macular edema
- Macular edema
- Corneal decompensation
- Corneal edema
- Pupillary block
- Iris Capture
- IOP >5mmHg over baseline and IOP >25 mmHg
- Significant glare and/or halos around lights
- Decentration/rotation of the IPCL V2.0
- Corneal endothelial cell loss
- Lens dislocation/rotation of the IPCL V2.0
- Loss of best spectacle connected visual acuity
- Secondary surgical intervention to remove/replace the IPCL V2.0

---

fr

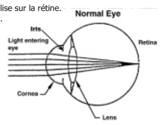
NOTICE D'INFORMATION DESTINÉE AU PATIENT

Type de dispositif : Lentille intraoculaire (phake)

Introduction
Cette notice d'information destinée au patient a été conçue pour vous aider à décider si vous souhaitez qu'une lentille de contact phake implantable (IPCL V2.0) soit implantée dans un ou dans les deux yeux afin de corriger votre myopie ou votre hypermétropie. Il est important de comprendre les avantages et les risques potentiels avant de prendre votre décision. Veuillez lire attentivement cette notice et discuter de toute question avec un médecin formé à la chirurgie de l'IPCL V2.0.

Qu'est-ce que la myopie et l'hypermétropie ?

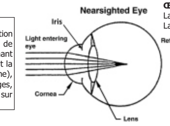
ŒIL NORMAL
La lumière se focalise sur la rétine.
La vision est nette.



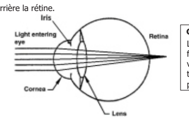
ŒIL NORMAL :
Votre œil fonctionne comme un appareil photo. Vous voyez les objets parce que votre œil focalise la lumière pour former des images. La couche transparente située à l'avant de votre œil, appelée cornée, ainsi que votre cristallin naturel, focalisent les rayons lumineux sur la surface arrière de l'œil appelée rétine.

ŒIL MYOPE
La lumière se focalise devant la rétine.
La vision est floue.

ŒIL MYOPE :
La myopie est un défaut de focalisation qui provoque une vision plus floue de loin que de près. La lumière provenant d'un objet éloigné se focalise devant la surface arrière de votre œil (la rétine), responsable de la capture des images, au lieu de se focaliser directement sur la rétine.



ŒIL HYPERMÉTROPE
La lumière se focalise derrière la rétine.
La vision est floue.

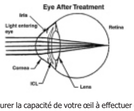


ŒIL HYPERMÉTROPE :
L'hypermétropie est un trouble visuel fréquent dans lequel vous pouvez voir clairement les objets éloignés, tandis que les objets proches peuvent apparaître flous.

Les lunettes et les lentilles de contact peuvent aider votre œil à focaliser correctement la lumière sur la rétine. L'IPCL V2.0 peut également aider votre œil à focaliser correctement la lumière sur la rétine.

Comment l'IPCL V2.0 corrige-t-elle la myopie et l'hypermétropie ?

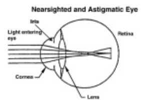
CORRECTION DE LA VISION APRÈS UNE CHIRURGIE IPCL V2.0



La dioptrie (D) est une unité utilisée pour mesurer la capacité de votre œil à effectuer correctement la mise au point. Elle indique le degré de myopie, d'hypermétropie ou d'astigmatisme dont vous êtes atteint. La chirurgie IPCL V2.0 peut traiter la myopie de -0,5 D à -15,0 D et l'hypermétropie de +0,5 D à +15,0 D. Si votre défaut visuel se situe dans ces plages, cette intervention peut vous aider à voir clairement sans lunettes ni lentilles de contact.

La lentille monofocale IPCL V2.0 ne corrige pas l'astigmatisme. L'astigmatisme est un trouble visuel fréquent qui provoque une vision floue ou irrégulière. Il survient lorsque la surface antérieure de l'œil (la cornée) n'a pas une forme parfaitement régulière. En conséquence, la lumière ne se focalise pas correctement à l'intérieur de l'œil et certaines parties de ce que vous voyez peuvent paraître plus nettes que d'autres.

ŒIL MYOPE ET ASTIGMATE



L'IPCL V2.0 Torique / IPCL V2.0 Presbyopique Torique peut corriger un astigmatisme compris entre +1,0 D et +10 D. Il vous est demandé de consulter votre médecin afin de choisir l'option la plus appropriée à votre œil.

Choisir la meilleure lentille pour votre vision
Il existe différents types de lentilles disponibles. Votre ophtalmologiste vous aidera à choisir celle qui vous convient le mieux. D'autres options de traitement comprennent les lunettes à verres épais ou les lentilles de contact au lieu d'un implant permanent. Discutez avec votre ophtalmologiste des avantages et des risques potentiels de chaque option.

Autres traitements pour corriger la myopie et l'hypermétropie?
Les autres traitements destinés à corriger la myopie et l'hypermétropie comprennent les lunettes, les lentilles de contact et les procédures chirurgicales réfractives.Les options chirurgicales comprennent la kératectomie photoréfractive (PRK), le laser in situ kératomileusis assisté par laser (LASIK), l'échange de cristallin réfractif (RLE) et l'implantation de lentilles intraoculaires phakes (par exemple l'IPCL V2.0). Toutefois, ces procédures peuvent ne pas répondre aux exigences visuelles de certaines professions, telles que le service militaire.

Ces procédures consistent soit à remodeler la cornée, soit à placer une lentille à l'intérieur de l'œil. La PRK et le LASIK utilisent un laser pour modifier la forme de la cornée afin d'améliorer la capacité de l'œil à effectuer la mise au point. Dans le LASIK, un fin volet cornéen est soulevé, le laser remodèle le tissu sous-jacent, puis le volet est repositionné afin de cicatriser. L'implantation d'une lentille intraoculaire phake, telle que l'IPCL V2.0, ajoute une lentille artificielle à l'intérieur de l'œil sans retirer votre cristallin naturel.

Avantages et risques de l'IPCL V2.0
La chirurgie IPCL V2.0 peut corriger en toute sécurité la myopie comprise entre –0,5 D et –15 D ainsi que l'hypermétropie comprise entre +0,5 D et +15 D. Si votre correction optique se situe dans ces plages, l'IPCL V2.0 peut améliorer votre vision de loin sans lunettes ni lentilles de contact.
L'implantation de l'IPCL V2.0 nécessite une intervention chirurgicale oculaire, qui comporte des risques potentiels. Veuillez lire attentivement cette notice et discuter avec votre médecin des risques éventuels.

■ **Quelques-uns de ces risques sont décrits ci-dessous.**

- Intervention chirurgicale supplémentaire

Dans certains cas, une seconde intervention peut être nécessaire pour retirer, remplacer ou ajuster l'IPCL V2.0. Elle peut également devoir être retirée lors d'une chirurgie de la cataracte. Une intervention supplémentaire peut aussi être nécessaire afin de réduire la pression intraoculaire.

- Formation d'une cataracte

Après une chirurgie avec une lentille intraoculaire phake, le risque que le cristallin naturel de votre œil devienne opaque est accru, ce qui peut entraîner une cataracte nécessitant une intervention chirurgicale. Plus l'IPCL V2.0 reste longtemps dans l'œil, plus ce risque augmente. Des examens oculaires réguliers sont importants afin de surveiller l'apparition éventuelle d'une cataracte. Les patients plus âgés ainsi que ceux présentant une myopie ou une hypermétropie plus importante peuvent présenter un risque plus élevé. Le risque à long terme au-delà de 7 ans n'est pas connu. Si une chirurgie de la cataracte devient nécessaire, l'IPCL V2.0 ainsi que le cristallin opacifié sont retirés et une nouvelle lentille est implantée, comme lors d'une chirurgie standard de la cataracte.

- Perte de la meilleure acuité visuelle corrigée (BCVA)

La cause la plus fréquente était l'opacification du cristallin naturel (cataracte). La vision peut s'améliorer dans ces cas après une chirurgie de la cataracte.

- Augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil et atteinte du nerf optique causée par une pression intraoculaire élevée (glaucome)

La pression normale à l'intérieur de l'œil (pression intraoculaire ou PIO) peut varier, mais elle est généralement comprise entre 10 et 21 millimètres de mercure (mmHg). Une pression intraoculaire supérieure à la normale est appelée hypertension oculaire et, si elle n'est pas traitée, peut provoquer une atteinte du nerf optique (glaucome) et entraîner une perte permanente de la vision.

■ **Perte de cellules endothéliales**
La cornée (la partie transparente située à l'avant de l'œil) possède une fine couche de cellules spécialisées appelées cellules endothéliales. Ces cellules maintiennent la transparence de la cornée en éliminant l'excès de liquide. Normalement, le nombre de ces cellules diminue lentement avec l'âge. Une chirurgie oculaire, y compris l'implantation de l'IPCL V2.0, peut entraîner une perte supplémentaire de ces cellules. Si un trop grand nombre de cellules est perdu, la cornée peut devenir trouble et affecter votre vision.
Avant l'intervention, votre médecin examinera vos yeux afin de déterminer si vous êtes un candidat approprié pour l'IPCL V2.0. Après l'intervention, une perte progressive de ces cellules peut continuer à se produire au fil du temps. Si un nombre trop important de cellules est perdu, du liquide peut s'accumuler dans la cornée (œdème cornéen), ce qui peut nécessiter une transplantation cornéenne.

■ **Autres complications**
Les autres risques associés à la chirurgie IPCL V2.0 peuvent inclure :
- déplacement de la partie colorée de l'œil (iris) à travers une plaie chirurgicale vers une position située à l'extérieur de l'œil (prolapsus de l'iris) ;
- saignement dans la zone de la rétine responsable de la vision de lecture (hémorragie maculaire) ;
- saignement sous la rétine (hémorragie sous-rétinienne) ;
- augmentation du défaut de réfraction (astigmatisme) ;
- soulèvement ou décollement de la rétine de sa position naturelle (décollement de la rétine) ;
- différence de taille entre les pupilles (anisocorie).

Les effets indésirables et complications liés à la chirurgie ou survenant après celle-ci, ainsi qu'à l'implantation d'une lentille de contact phake implantable, peuvent inclure notamment, sans s'y limiter :

- Augmentation de l'astigmatisme
- Erreur de réfraction
- Infection intraoculaire
- Perte de vitré
- Problème de voûte (vaulting)
- Cataracte sous-capsulaire antérieure
- Inflammation intraoculaire sévère
- Glaucome
- Glaucome secondaire
- Uvéite
- Vitréite
- Hyphéma
- Hypopyon
- Sous-correction/surcorrection
- Pupille non réactive
- Endophtalmie
- Syndrome TASS (syndrome toxique du segment antérieur)
- Décollement de la rétine
- Irite
- Œdème maculaire cystoïde
- Œdème maculaire

---

de

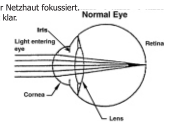
PATIENTENINFORMATIONSBLATT

Produkttyp: Intraokularlinse (phak)

Einleitung
Dieses Patienteninformationsblatt soll Ihnen dabei helfen zu entscheiden, ob bei Ihnen eine implantierbare phake Kontaktlinse (IPCL V2.0) in einem oder beiden Augen eingesetzt werden soll, um Ihre Kurzsichtigkeit (Myopie) oder Weitsichtigkeit (Hyperopie) zu korrigieren. Es ist wichtig, die Vorteile und möglichen Risiken zu verstehen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt sorgfältig durch und besprechen Sie alle Fragen mit einem Arzt, der in der IPCL V2.0-Chirurgie geschult ist.

Was sind Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit?

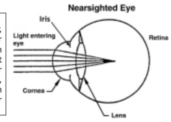
NORMALES AUGE
Das Licht wird auf der Netzhaut fokussiert.
Das Sehvermögen ist klar.



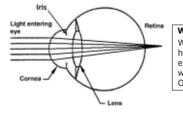
NORMALES AUGE:
Ihr Auge funktioniert wie eine Kamera. Sie sehen Objekte, weil Ihr Auge das Licht zu Bildern fokussiert. Sowohl die transparente vordere Schicht Ihres Auges, die Hornhaut, als auch Ihre natürliche Augenlinse bündeln die Lichtstrahlen auf die Rückseite des Auges, die sogenannte Netzhaut.

KURZSICHTIGES AUGE
Das Licht wird vor der Netzhaut fokussiert.
Das Sehvermögen ist unscharf.

KURZSICHTIGES AUGE:
Kurzsichtigkeit ist ein Brechungsfehler, der dazu führt, dass das Sehen in der Ferne unschärfer ist als das Sehen in der Nähe. Das Licht eines weit entfernten Objekts wird vor der Rückseite Ihres Auges (der Netzhaut), die für die Bildaufnahme verantwortlich ist, fokussiert, anstatt direkt auf der Netzhaut.



WEITSICHTIGES AUGE
Das Licht wird hinter der Netzhaut fokussiert.
Das Sehvermögen ist unscharf.

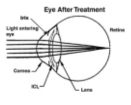


WEITSICHTIGES AUGE:
Weitsichtigkeit (Hyperopie) ist eine häufige Sehschwäche, bei der entfernte Objekte klar gesehen werden können, während nahe Objekte unscharf erscheinen können.

Brillen und Kontaktlinsen können Ihrem Auge helfen, das Licht korrekt auf die Netzhaut zu fokussieren. Auch die IPCL V2.0 kann Ihrem Auge helfen, das Licht korrekt auf die Netzhaut zu fokussieren.

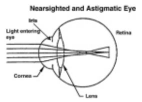
Wie korrigiert die IPCL V2.0 Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit?

SEHKORREKTUR NACH EINER IPCL V2.0-OPERATION



Eine Dioptrie (D) ist eine Maßeinheit zur Bestimmung der Fokussierungsfähigkeit Ihres Auges. Sie zeigt den Grad Ihrer Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Ihres Astigmatismus an. Die IPCL V2.0-Operation kann Kurzsichtigkeit von -0,5 D bis -15,0 D und Weitsichtigkeit von +0,5 D bis +15,0 D behandeln. Wenn Ihre Fehlsichtigkeit innerhalb dieser Bereiche liegt, kann Ihnen diese Operation helfen, ohne Brille oder Kontaktlinsen klar zu sehen.
Die monofokale IPCL V2.0 korrigiert keinen Astigmatismus. Astigmatismus ist eine häufige Sehstörung, die verschwommenes oder ungleichmäßiges Sehen verursacht. Er entsteht, wenn die Vorderfläche des Auges (Hornhaut) nicht gleichmäßig geformt ist. Dadurch wird das Licht im Auge nicht korrekt fokussiert, und einige Bereiche des Sichtfeldes können schärfer erscheinen als andere.

KURZSICHTIGES UND ASTIGMATISCHES AUGE



Die IPCL V2.0 Toric / IPCL V2.0 Presbyopic Toric kann Astigmatismus von +1,0 D bis +10 D korrigieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, um die für Ihr Auge am besten geeignete Option auszuwählen.

Die beste Linse für Ihr Sehvermögen auswählen
Es stehen verschiedene Linsentypen zur Verfügung. Ihr Augenarzt wird Ihnen helfen, die für Sie am besten geeignete Linse auszuwählen. Weitere Behandlungsmöglichkeiten umfassen Brillen mit dicken Gläsern oder Kontaktlinsen anstelle eines permanenten Linsenimplantats. Sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt über die Vorteile und möglichen Risiken jeder Option.

Andere Behandlungsmöglichkeiten zur Korrektur von Kurz- und Weitsichtigkeit?
Zu den anderen Behandlungsmöglichkeiten zur Korrektur von Kurz- und Weitsichtigkeit gehören Brillen, Kontaktlinsen und refraktive chirurgische Verfahren. Zu den chirurgischen Optionen zählen die photorefraktive Keratektomie (PRK), die laserassistierte In-situ-Keratomileusis (LASIK), der refraktive Linsenaustausch (RLE) sowie die Implantation einer phaken Intraokularlinse (z. B. IPCL V2.0). Diese Verfahren erfüllen jedoch möglicherweise nicht die Sehanforderungen bestimmter Berufe, beispielsweise im Militärdienst.

Diese Verfahren verändern entweder die Form der Hornhaut oder platzieren eine Linse im Inneren des Auges. PRK und LASIK verwenden einen Laser, um die Form der Hornhaut zu verändern und dadurch die Fokussierungsfähigkeit des Auges zu verbessern. Bei LASIK wird ein dünner Hornhautlappen angehoben, das darunterliegende Gewebe mit dem Laser geformt und der Hornhautlappen anschließend wieder zurückgelegt, damit er verheilen kann. Die Implantation einer phaken Intraokularlinse, wie der IPCL V2.0, fügt dem Auge eine künstliche Linse hinzu, ohne die natürliche Linse zu entfernen.

Vorteile und Risiken der IPCL V2.0
Die IPCL V2.0-Operation kann Kurzsichtigkeit zwischen –0,5 D und –15 D sowie Weitsichtigkeit zwischen +0,5 D und +15 D sicher korrigieren. Liegt Ihre Brillenstärke innerhalb dieser Bereiche, kann die IPCL V2.0 Ihr Sehen in der Ferne ohne Brille oder Kontaktlinsen verbessern.
Die Implantation einer IPCL V2.0 erfordert einen chirurgischen Eingriff am Auge, der potenzielle Risiken mit sich bringt. Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt sorgfältig durch und sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die möglichen Risiken.

■ **Einige dieser Risiken sind nachfolgend aufgeführt.**
- Zusätzliche Operation

In manchen Fällen kann ein zweiter chirurgischer Eingriff erforderlich sein, um die IPCL V2.0 zu entfernen, auszutauschen oder anzupassen. Sie muss möglicherweise während einer Kataraktoperation entfernt werden. Eine zusätzliche Operation kann auch erforderlich sein, um den Augeninnendruck zu senken.

- Kataraktbildung

Nach einer Operation mit einer phaken Intraokularlinse besteht ein erhöhtes Risiko, dass die natürliche Linse Ihres Auges eintrübt und sich ein Katarakt entwickelt, der operativ behandelt werden muss. Je länger die IPCL V2.0 im Auge verbleibt, desto höher wird dieses Risiko. Regelmäßige Augenuntersuchungen sind wichtig, um die Entwicklung eines Katarakts zu überwachen. Ältere Patienten sowie Patienten mit stärkerer Kurz- oder Weitsichtigkeit können ein höheres Risiko aufweisen. Das Langzeitrisiko über einen Zeitraum von mehr als 7 Jahren hinaus ist nicht bekannt. Falls eine Kataraktoperation erforderlich wird, werden die IPCL V2.0 und die eingetrübte Linse entfernt und wie bei einer routinemäßigen Kataraktoperation eine neue Linse implantiert.

- Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)

Die häufigste Ursache war die Eintrübung der natürlichen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen dieser Augen verbessern.

- Erhöhter Augeninnendruck und Schädigung des Sehnervs durch erhöhten Augeninnendruck (Glaukom)

Der normale Augeninnendruck (intraokularer Druck oder IOD) kann variieren, liegt jedoch üblicherweise zwischen 10 und 21 Millimeter Quecksilbersäule (mmHg). Ein höherer als normaler Augeninnendruck wird als okuläre Hypertonie bezeichnet und kann unbehandelt zu einer Schädigung des Sehnervs (Glaukom) und zu dauerhaftem Sehverlust führen.

■ **Verlust von Endothelzellen**
Die Hornhaut (der klare vordere Teil Ihres Auges) besitzt eine dünne Schicht spezieller Zellen, die als Endothelzellen bezeichnet werden. Diese Zellen halten die Hornhaut klar, indem sie überschüssige Flüssigkeit entfernen. Normalerweise nimmt die Anzahl dieser Zellen mit zunehmendem Alter langsam ab. Augenoperationen, einschließlich der Implantation einer IPCL V2.0, können einen zusätzlichen Verlust dieser Zellen verursachen. Wenn zu viele Zellen verloren gehen, kann die Hornhaut trüb werden und Ihr Sehvermögen beeinträchtigen.
Vor der Operation wird Ihr Arzt Ihre Augen untersuchen, um festzustellen, ob Sie für die IPCL V2.0 geeignet sind. Nach der Operation kann im Laufe der Zeit weiterhin ein gewisser Verlust dieser Zellen auftreten. Gehen zu viele Zellen verloren, kann sich Flüssigkeit in der Hornhaut ansammeln (Hornhautödem), was möglicherweise eine Hornhauttransplantation erforderlich macht.

■ **Weitere Komplikationen**
Weitere Risiken im Zusammenhang mit einer IPCL V2.0-Operation können sein:
- Verlagerung des farbigen Teils des Auges (Iris) durch eine Operationswunde in eine Position außerhalb des Auges (Irisprolaps),
- Blutung im Bereich der Netzhaut, der für das Lesevermögen verantwortlich ist (Makulablutung),
- Blutung unter der Netzhaut (subretinale Blutung),
- Zunahme des Brechungsfehlers (Astigmatismus),
- Ablösung oder Zug der Netzhaut aus ihrer natürlichen Position (Netzhautablösung),
- Ungleich große Pupillen (Anisokorie).

Nebenwirkungen und Komplikationen infolge oder nach einer Operation sowie der Implantation einer implantierbaren phaken Kontaktlinse können unter anderem Folgendes umfassen:

- Zunahme des Astigmatismus
- Refraktionsfehler
- Intraokulare Infektion
- Verlust von Glaskörpergewebe
- Vaulting-Problem
- Anteriore subkapsuläre Katarakt
- Schwere intraokulare Entzündung
- Glaukom
- Sekundäres Glaukom
- Uveitis
- Vitritis
- Hyphäma
- Hypopyon
- Unterkorrektur/Überkorrektur
- Nicht reagierende Pupille
- Endophthalmitis
- TASS (Toxic Anterior Segment Syndrome)
- Netzhautablösung
- Iritis
- Zystoides Makulaödem
- Makulaödem
- Hornhautdekompensation
- Hornhautödem
- Pupillenblock
- Iris-Capture

---

it

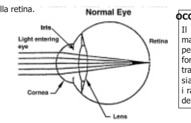
FOGLIO INFORMATIVO PER IL PAZIENTE

Tipo di Dispositivo: Lente Intraoculare (Facica)

Introduzione
Questo foglio informativo per il paziente è stato progettato per aiutarla a decidere se desidera l'impianto di una Lente a Contatto Facica Impiantabile (IPCL V2.0) in uno o entrambi gli occhi per correggere la miopia o l'ipermetropia. È importante comprendere i benefici e i possibili rischi prima di prendere una decisione. La invitiamo a leggere attentamente questo foglio informativo e a discutere eventuali domande con un medico specializzato nella chirurgia IPCL V2.0.

Che cosa sono la miopia e l'ipermetropia?

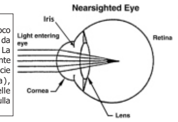
OCCHIO NORMALE
La luce si focalizza sulla retina.
La visione è nitida.



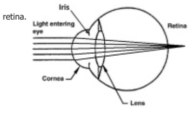
OCCHIO NORMALE:
Il vostro occhio funziona come una macchina fotografica. Vedete gli oggetti perché l'occhio mette a fuoco la luce formando immagini. Sia lo strato anteriore trasparente dell'occhio, chiamato cornea, sia il cristallino naturale focalizzano i raggi luminosi sulla superficie posteriore dell'occhio, chiamata retina.

OCCHIO MIOPE
La luce si focalizza davanti alla retina.
La visione è sfocata.

OCCHIO MIOPE:
La miopia è un difetto di messa a fuoco che provoca una visione più sfocata da lontano rispetto a quella da vicino. La luce proveniente da un oggetto distante viene focalizzata davanti alla superficie posteriore dell'occhio (retina), responsabile della formazione delle immagini, anziché direttamente sulla retina.



OCCHIO IPERMETROPE
La luce si focalizza dietro la retina.
La visione è sfocata.

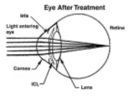


OCCHIO IPERMETROPE:
L'ipermetropia è un comune difetto visivo in cui è possibile vedere chiaramente gli oggetti lontani, mentre quelli vicini possono apparire sfocati.

Gli occhiali e le lenti a contatto possono aiutare l'occhio a focalizzare correttamente la luce sulla retina. Anche la IPCL V2.0 può aiutare l'occhio a focalizzare correttamente la luce sulla retina.

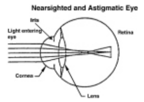
Come corregge la IPCL V2.0 la miopia e l'ipermetropia?

CORREZIONE DELLA VISIONE DOPO L'INTERVENTO CON IPCL V2.0



La diottria (D) è un'unità di misura utilizzata per valutare la capacità dell'occhio di mettere a fuoco. Indica il grado di miopia, ipermetropia o astigmatismo presente. L'intervento con IPCL V2.0 può correggere la miopia da -0,5 D a -15,0 D e l'ipermetropia da +0,5 D a +15,0 D. Se il vostro difetto visivo rientra in questi intervalli, questo intervento può aiutarvi a vedere chiaramente senza occhiali o lenti a contatto.
La lente monofocale IPCL V2.0 non corregge l'astigmatismo. L'astigmatismo è un comune difetto visivo che provoca una visione sfocata o irregolare. Si verifica quando la superficie anteriore dell'occhio (cornea) non ha una forma uniforme. Per questo motivo, la luce non viene focalizzata correttamente all'interno dell'occhio e alcune parti di ciò che vedete possono apparire più nitide di altre.

OCCHIO MIOPE E ASTIGMATICO



La IPCL V2.0 Torica / IPCL V2.0 Presbiopica Torica può correggere l'astigmatismo da +1,0 D fino a +10 D. Vi invitiamo a consultare il vostro medico per scegliere l'opzione più appropriata e adatta ai vostri occhi.

Scelta della lente migliore per la vostra vista
Sono disponibili diversi tipi di lenti. Il vostro oculista vi aiuterà a scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Altre opzioni di trattamento includono occhiali con lenti spesse o lenti a contatto in alternativa a un impianto permanente. Parlate con il vostro oculista dei benefici e dei possibili rischi di ciascuna opzione.

Altri trattamenti per correggere miopia e ipermetropia?
Altri trattamenti per correggere la miopia e l'ipermetropia includono occhiali, lenti a contatto e procedure chirurgiche refrattive. Le opzioni chirurgiche comprendono la Cheratectomia Fotorefrattiva (PRK), la Cheratomileusi Laser Assistita In Situ (LASIK), la Sostituzione Refrattiva del Cristallino (RLE) e l'impianto di una lente intraoculare facica (ad esempio IPCL V2.0). Tuttavia, queste procedure potrebbero non soddisfare i requisiti visivi richiesti per alcune professioni, come il servizio militare.

Queste procedure modificano la forma della cornea oppure prevedono l'inserimento di una lente all'interno dell'occhio. La PRK e la LASIK utilizzano un laser per modificare la forma della cornea in modo che l'occhio possa mettere a fuoco meglio. Nella LASIK, un sottile lembo corneale viene sollevato, il laser rimodella il tessuto sottostante e il lembo viene poi riposizionato affinché possa guarire. L'impianto di una lente intraoculare facica, come la IPCL V2.0, aggiunge una lente artificiale all'interno dell'occhio senza rimuovere il cristallino naturale.

Benefici e rischi della IPCL V2.0
L'intervento con IPCL V2.0 può correggere in modo sicuro la miopia compresa tra –0,5 D e –15 D e l'ipermetropia compresa tra +0,5 D e +15 D. Se la vostra prescrizione per occhiali rientra in questi intervalli, la IPCL V2.0 può migliorare la vostra visione da lontano senza la necessità di occhiali o lenti a contatto.
L'impianto della IPCL V2.0 richiede un intervento chirurgico oculare che comporta potenziali rischi. Vi invitiamo a leggere attentamente questo foglio informativo e a discutere con il vostro medico i possibili rischi.

■ **Alcuni dei rischi sono riportati di seguito.**
- Intervento chirurgico aggiuntivo

In alcuni casi può essere necessario un secondo intervento per rimuovere, sostituire o regolare la IPCL V2.0. Potrebbe essere necessario rimuoverla durante un intervento di cataratta. Un ulteriore intervento potrebbe anche essere richiesto per ridurre la pressione intraoculare.

- Formazione della cataratta

Dopo l'impianto di una IOL facica, esiste un rischio aumentato che il cristallino naturale dell'occhio diventi opaco, causando una cataratta che potrebbe richiedere un intervento chirurgico. Più a lungo la IPCL V2.0 rimane nell'occhio, maggiore diventa questo rischio. Sono importanti controlli oculistici regolari per monitorare l'eventuale comparsa della cataratta. I pazienti più anziani e quelli con miopia o ipermetropia più elevate possono presentare un rischio maggiore. Il rischio a lungo termine oltre i 7 anni non è noto. Se si rende necessario un intervento di cataratta, la IPCL V2.0 e il cristallino opacizzato vengono rimossi e viene impiantata una nuova lente, come avviene nella normale chirurgia della cataratta.

- Perdita della Migliore Acuità Visiva Correggibile (BCVA)

La causa più comune era l'opacizzazione del cristallino naturale (cataratta). In questi occhi la vista può migliorare dopo l'intervento di cataratta.

- Aumento della pressione intraoculare e danno al nervo ottico causato da una pressione elevata nell'occhio (Glaucoma)

La pressione normale dell'occhio (pressione intraoculare o IOP) può variare, ma è generalmente considerata compresa tra 10 e 21 millimetri di mercurio (mmHg). Una IOP superiore alla norma è definita ipertensione oculare e, se non trattata, può causare danni al nervo ottico (glaucoma) e portare a una perdita permanente della vista.

■ **Perdita delle Cellule Endoteliali**
La cornea (la parte anteriore trasparente dell'occhio) possiede un sottile strato di cellule specializzate chiamate cellule endoteliali. Queste cellule mantengono la cornea trasparente eliminando il liquido in eccesso. Normalmente, il numero di queste cellule diminuisce lentamente con l'età. La chirurgia oculare, compreso l'impianto della IPCL V2.0, può causare una perdita aggiuntiva di tali cellule. Se vengono perse troppe cellule, la cornea può diventare opaca e compromettere la vista.
Prima dell'intervento, il medico esaminerà i vostri occhi per verificare se siete idonei all'impianto della IPCL V2.0. Dopo l'intervento, può verificarsi nel tempo una continua perdita di queste cellule. Se la perdita è eccessiva, può accumularsi liquido nella cornea (edema corneale), condizione che può richiedere un trapianto di cornea.

■ **Altre Complicanze**
Altri rischi associati alla chirurgia con IPCL V2.0 possono includere:
- spostamento della parte colorata dell'occhio (iride) attraverso una ferita chirurgica verso una posizione esterna all'occhio (prolasso dell'iride),
- sanguinamento nell'area della retina responsabile della visione per la lettura (emorragia maculare),
- sanguinamento sotto la retina (emorragia sottoretinica),
- aumento del difetto refrattivo (astigmatismo),
- sollevamento o trazione della retina dalla sua posizione naturale (distacco di retina),
- dimensioni non uguali delle pupille (anisocoria).

Le reazioni avverse e le complicanze dovute a, o successive all'intervento chirurgico e all'impianto di qualsiasi Lente a Contatto Facica Impiantabile possono includere, ma non sono limitate a:

- Aumento dell'astigmatismo
- Errore refrattivo
- Infezione intraoculare
- Perdita di vitreo
- Problemi di vaulting
- Cataratta sottocapsulare anteriore
- Grave infiammazione intraoculare
- Glaucoma
- Glaucoma secondario
- Uveite
- Vitrite
- Ifema
- Ipopion
- Sottocorrezione/Sovracorrezione
- Pupilla non reattiva
- Endoftalmite
- TASS (Sindrome Tossica del Segmento Anteriore)
- Distacco di retina
- Irite
- Edema maculare cistoide
- Edema maculare
- Scompenso corneale
- Edema corneale
- Blocco pupillare
- Cattura dell'iride
- IOP > 5 mmHg rispetto al valore basale e IOP > 25 mmHg

---

pt

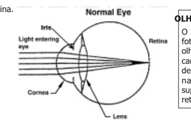
FOLHETO INFORMATIVO PARA O PACIENTE

Tipo de Dispositivo: Lente Intraocular (Fácica)

Introdução
Este folheto informativo para o paciente foi concebido para o ajudar a decidir se pretende que seja implantada uma Lente de Contacto Fácica Implantável (IPCL V2.0) num ou em ambos os olhos para corrigir a sua miopia (visão ao longe deficiente) ou hipermetropia (visão ao perto deficiente). É importante compreender os benefícios e os possíveis riscos antes de tomar a sua decisão. Leia atentamente este folheto e discuta quaisquer dúvidas com um médico treinado em cirurgia IPCL V2.0.

O que é a miopia e a hipermetropia?

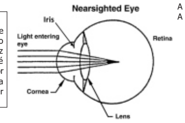
OLHO NORMAL
A luz é focada na retina.
A visão é nítida.



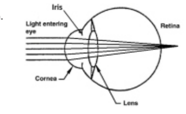
OLHO NORMAL:
O seu olho funciona como uma câmara fotográfica. Vê os objetos porque o seu olho foca a luz em imagens. Tanto a camada frontal transparente do olho, denominada córnea, como o seu cristalino natural focam os raios de luz na superfície posterior do olho, denominada retina.

OLHO MÍOPE
A luz é focada à frente da retina.
A visão é desfocada.

OLHO MÍOPE:
A miopia é um erro de focagem que provoca uma visão mais desfocada ao longe do que ao perto. A luz proveniente de um objeto distante é focada à frente da superfície posterior do olho (retina), responsável pela captação das imagens, em vez de ser focada diretamente sobre a retina.



OLHO HIPERMÉTROPE
A luz é focada atrás da retina.
A visão é desfocada.

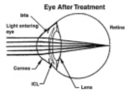


OLHO HIPERMÉTROPE:
A hipermetropia é uma condição visual comum em que consegue ver claramente os objetos distantes, mas os objetos próximos podem parecer desfocados.

Os óculos e as lentes de contacto podem ajudar o seu olho a focar corretamente a luz na retina. A IPCL V2.0 também pode ajudar o seu olho a focar corretamente a luz na retina.

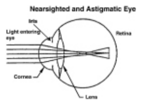
Como a IPCL V2.0 corrige a miopia e a hipermetropia?

CORREÇÃO DA VISÃO APÓS A CIRURGIA COM IPCL V2.0



A dioptria (D) é uma unidade utilizada para medir a capacidade de focagem do olho. Indica o grau de miopia, hipermetropia ou astigmatismo que possui. A cirurgia com IPCL V2.0 pode tratar a miopia de -0,5 D a -15,0 D e a hipermetropia de +0,5 D a +15,0 D. Se a sua visão se encontrar dentro destes intervalos, esta cirurgia poderá ajudá-lo a ver claramente sem óculos ou lentes de contacto.
A lente monofocal IPCL V2.0 não corrige o astigmatismo. O astigmatismo é um problema visual comum que provoca visão desfocada ou irregular. Ocorre quando a superfície frontal do olho (córnea) não tem uma forma uniforme. Como resultado, a luz não é focada corretamente no interior do olho e algumas partes do que vê podem parecer mais nítidas do que outras.

OLHO MÍOPE E ASTIGMÁTICO



A IPCL V2.0 Tórica / IPCL V2.0 Tórica para Presbiopia pode corrigir qualquer astigmatismo entre +1,0 D e +10 D. Recomenda-se que consulte os seus médicos para escolher as opções mais adequadas para o seu olho.

Escolher a melhor lente para a sua visão
Existem diferentes tipos de lentes disponíveis. O seu oftalmologista ajudá-lo-á a escolher a que melhor se adequa a si. Outras opções de tratamento incluem óculos com lentes espessas ou lentes de contacto em vez de um implante permanente. Fale com o seu oftalmologista sobre os benefícios e os possíveis riscos de cada opção.

Outros tratamentos para corrigir a miopia e a hipermetropia
Outros tratamentos para corrigir a miopia e a hipermetropia incluem óculos, lentes de contacto e procedimentos cirúrgicos refrativos. As opções cirúrgicas incluem a Ceratectomia Fotorrefrativa (PRK), a Ceratomileuse Assistida por Laser In Situ (LASIK), a troca refrativa do cristalino (RLE) e a implantação de lentes intraoculares fácicas (por exemplo, IPCL V2.0). No entanto, estes procedimentos podem não satisfazer os requisitos visuais de determinadas profissões, como o serviço militar.
Estes procedimentos remodelam a córnea ou colocam uma lente no interior do olho. A PRK e o LASIK utilizam um laser para alterar a forma da córnea, permitindo que o olho foque melhor. No LASIK, é levantado um fino retalho da córnea, o laser remodela o tecido subjacente e o retalho é recolocado para cicatrização. A implantação de uma lente intraocular fácica, como a IPCL V2.0, adiciona uma lente artificial no interior do olho sem remover o cristalino natural.

Benefícios e riscos da IPCL V2.0
A cirurgia com IPCL V2.0 pode corrigir de forma segura a miopia entre –0,5 D e –15 D e a hipermetropia entre +0,5 D e +15 D. Se a sua graduação ocular se enquadrar nestes intervalos, a IPCL V2.0 poderá melhorar a sua visão ao longe sem necessidade de correção com óculos ou lentes de contacto.
A implantação da IPCL V2.0 requer cirurgia ocular, a qual envolve riscos potenciais. Leia atentamente este folheto e converse com o seu médico sobre os possíveis riscos.

■ **Alguns dos riscos incluem:**
- Cirurgia adicional

Por vezes, pode ser necessária uma segunda cirurgia para remover, substituir ou ajustar a IPCL V2.0. A lente pode necessitar de ser removida durante uma cirurgia às cataratas. Também poderá ser necessária uma cirurgia adicional para reduzir a pressão ocular.

- Formação de catarata

Após a cirurgia com LIO fácica, existe um risco aumentado de o cristalino natural do olho se tornar opaco, levando ao desenvolvimento de cataratas que poderão necessitar de cirurgia. Quanto mais tempo a IPCL V2.0 permanecer no olho, maior será este risco. Os exames oftalmológicos regulares são importantes para monitorizar o aparecimento de cataratas. Os pacientes mais idosos e aqueles com miopia ou hipermetropia mais acentuadas podem apresentar um risco mais elevado. O risco a longo prazo para além de 7 anos é desconhecido.
Se for necessária cirurgia às cataratas, a IPCL V2.0 e o cristalino opacificado serão removidos e será implantada uma nova lente, tal como acontece numa cirurgia convencional às cataratas.

- Perda da Melhor Acuidade Visual Corrigida (BCVA)

A causa mais comum foi a opacificação do cristalino natural (catarata). A visão pode melhorar nestes olhos após a cirurgia às cataratas.

- Aumento da pressão intraocular e lesão do nervo ótico causada pelo aumento da pressão no olho (Glaucoma)

A pressão ocular normal (pressão intraocular ou PIO) pode variar, mas é geralmente considerada entre 10 e 21 milímetros de mercúrio (mmHg). Uma PIO superior ao normal é denominada hipertensão ocular e, se não for tratada, pode causar danos no nervo ótico (glaucoma) e provocar perda permanente da visão.

■ **Perda de células endoteliais**
A córnea (a parte frontal transparente do olho) possui uma fina camada de células especiais denominadas células endoteliais. Estas células mantêm a córnea transparente removendo o excesso de fluido. Normalmente, o número destas células diminui lentamente com a idade. A cirurgia ocular, incluindo a IPCL V2.0, pode causar uma perda adicional destas células. Se forem perdidas demasiadas células, a córnea pode tornar-se opaca e afetar a visão. Antes da cirurgia, o seu médico examinará os seus olhos para verificar se é um candidato adequado para a IPCL V2.0. Após a cirurgia, pode ocorrer alguma perda contínua destas células ao longo do tempo. Se forem perdidas demasiadas células, pode acumular-se líquido na córnea (denominado edema corneano), o que poderá exigir um transplante de córnea.

■ **Outras complicações**
Outros riscos associados à cirurgia com IPCL V2.0 podem incluir:
- deslocação da parte colorida do olho (íris) através de uma ferida cirúrgica para uma posição fora do olho (prolapso da íris),
- hemorragia na área da retina responsável pela visão de leitura (hemorragia macular),
- hemorragia sob a retina (hemorragia sub-retiniana),
- aumento do erro refrativo (astigmatismo),
- elevação ou tração da retina da sua posição natural (descolamento da retina),
- tamanho desigual das pupilas (anisocoria).

As reações adversas e complicações decorrentes da cirurgia e da implantação de qualquer Lente de Contacto Fácica Implantável podem incluir, mas não se limitam a:

- Aumento do astigmatismo
- Erro refrativo
- Infeção intraocular
- Perda de vítreo
- Problema de vaulting
- Catarata subcapsular anterior
- Inflamação intraocular grave
- Glaucoma
- Glaucoma secundário
- Uveíte
- Vitrite
- Hifema
- Hipópio
- Subcorreção/sobrecorreção
- Pupila não reativa
- Endoftalmite
- TASS
- Descolamento da retina
- Irite
- Edema macular cistoide
- Edema macular
- Descompensação corneana
- Edema corneano
- Bloqueio pupilar
- Captura da íris
- PIO >5 mmHg acima do valor basal e PIO >25 mmHg

---

es

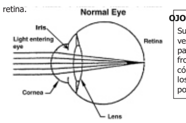
FOLLETO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Tipo de dispositivo: Lente Intraocular (Fáquica)

Introducción
Este folleto de información para el paciente está diseñado para ayudarle a decidir si desea que se le implante una Lente de Contacto Fáquica Implantable (IPCL V2.0) en uno o ambos ojos para corregir su miopía o hipermetropía. Es importante comprender los beneficios y los posibles riesgos antes de tomar su decisión. Lea atentamente este folleto y consulte cualquier duda con un médico capacitado en cirugía IPCL V2.0.

¿Qué son la miopía y la hipermetropía?

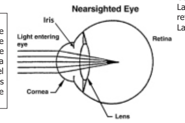
OJO NORMAL
La luz se enfoca en la retina.
La visión es nítida.



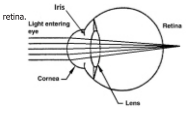
OJO NORMAL:
Su ojo funciona como una cámara. Usted ve los objetos porque su ojo enfoca la luz para formar imágenes. Tanto la capa frontal transparente del ojo, llamada córnea, como el cristalino natural enfocan los rayos de luz sobre la superficie posterior del ojo, llamada retina.

OJO MIOPE
La luz se enfoca delante de la retina.
La visión es borrosa.

OJO MIOPE:
La miopía es un error de enfoque que provoca una visión más borrosa de lejos que de cerca. La luz procedente de un objeto distante se enfoca delante de la superficie posterior del ojo (retina), responsable de captar las imágenes, en lugar de enfocarse directamente sobre la retina.



OJO HIPERMÉTROPE
La luz se enfoca detrás de la retina.
La visión es borrosa.

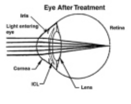


OJO HIPERMÉTROPE:
La hipermetropía es una afección visual común en la que puede ver claramente los objetos lejanos, pero los objetos cercanos pueden verse borrosos.

Las gafas y las lentes de contacto pueden ayudar a que el ojo enfoque correctamente la luz sobre la retina. La IPCL V2.0 también puede ayudar a que el ojo enfoque correctamente la luz sobre la retina.

¿Cómo corrige la IPCL V2.0 la miopía y la hipermetropía?

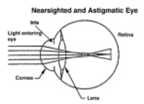
CORRECCIÓN DE LA VISIÓN DESPUÉS DE LA CIRUGÍA IPCL V2.0



Una dioptría (D) es una unidad utilizada para medir la capacidad de enfoque del ojo. Indica el grado de miopía, hipermetropía o astigmatismo que presenta. La cirugía IPCL V2.0 puede tratar la miopía de -0,5 D a -15,0 D y la hipermetropía de +0,5 D a +15,0 D. Si su visión se encuentra dentro de estos rangos, esta cirugía puede ayudarle a ver con claridad sin necesidad de gafas o lentes de contacto.

La lente monofocal IPCL V2.0 no corrige el astigmatismo. El astigmatismo es un problema visual frecuente que provoca visión borrosa o irregular. Ocurre cuando la superficie frontal del ojo (córnea) no tiene una forma uniforme. Como resultado, la luz no se enfoca correctamente dentro del ojo y algunas partes de lo que ve pueden parecer más claras que otras.

OJO MIOPE Y ASTIGMÁTICO



IPCL V2.0 Tórica / IPCL V2.0 Tórica para Presbicia puede corregir el astigmatismo que presente desde +1,0 D hasta +10 D. Se le recomienda consultar con su médico para elegir la opción más adecuada para su ojo.

Cómo elegir la mejor lente para su visión
Existen diferentes tipos de lentes disponibles. Su oftalmólogo le ayudará a elegir la que mejor se adapte a usted. Otras opciones de tratamiento incluyen gafas con lentes gruesas o lentes de contacto en lugar de un implante permanente. Hable con su oftalmólogo sobre los beneficios y los posibles riesgos de cada opción.

¿Qué otros tratamientos existen para corregir la miopía y la hipermetropía?
Otros tratamientos para corregir la miopía y la hipermetropía incluyen gafas, lentes de contacto y procedimientos quirúrgicos refractivos. Las opciones quirúrgicas incluyen la queratectomía fotorrefractiva (PRK), la queratomileusis in situ asistida por láser (LASIK), el intercambio de cristalino refractivo (RLE) y la implantación de lentes intraoculares fáquicas (por ejemplo, IPCL V2.0). Sin embargo, estos procedimientos pueden no cumplir con los requisitos visuales de determinadas profesiones, como el servicio militar.

Estos procedimientos remodelan la córnea o colocan una lente dentro del ojo. La PRK y el LASIK utilizan un láser para modificar la forma de la córnea y mejorar el enfoque del ojo. En el LASIK, se levanta una fina lámina de la córnea, el láser remodela el tejido subyacente y posteriormente la lámina se recoloca para que cicatrice. La implantación de una lente intraocular fáquica, como la IPCL V2.0, añade una lente artificial dentro del ojo sin retirar el cristalino natural.

Beneficios y riesgos de la IPCL V2.0
La cirugía IPCL V2.0 puede corregir de forma segura la miopía entre –0,5 D y –15 D, y la hipermetropía entre +0,5 D y +15 D. Si su graduación se encuentra dentro de estos rangos, la IPCL V2.0 puede mejorar su visión lejana sin necesidad de gafas o lentes de contacto.
La implantación de la IPCL V2.0 requiere cirugía ocular, la cual conlleva riesgos potenciales. Lea atentamente este folleto y consulte con su médico sobre los posibles riesgos.

■ **Algunos de los riesgos son los siguientes:**
- Cirugía adicional

En ocasiones puede ser necesaria una segunda intervención quirúrgica para retirar, reemplazar o ajustar la IPCL V2.0. Puede ser necesario retirarla durante una cirugía de cataratas. También puede requerirse una cirugía adicional para reducir la presión ocular.

- Formación de cataratas

Después de la cirugía con una lente intraocular fáquica, existe un mayor riesgo de que el cristalino natural del ojo se vuelva opaco, provocando cataratas que podrían requerir cirugía. Cuanto más tiempo permanezca la IPCL V2.0 dentro del ojo, mayor será este riesgo. Los exámenes oculares periódicos son importantes para detectar la aparición de cataratas. Los pacientes de mayor edad y aquellos con grados más elevados de miopía o hipermetropía pueden presentar un riesgo superior. Se desconoce el riesgo a largo plazo más allá de los 7 años.
Si se requiere cirugía de cataratas, se retirarán tanto la IPCL V2.0 como el cristalino opaco, y se implantará una nueva lente, de forma similar a una cirugía de cataratas convencional.

- Pérdida de la Mejor Agudeza Visual Corregida (BCVA)

La causa más frecuente fue la opacificación del cristalino natural (catarata). La visión puede mejorar en estos ojos después de la cirugía de cataratas.

- Aumento de la presión dentro del ojo y daño al nervio óptico causado por el incremento de la presión ocular (Glaucoma)

La presión ocular normal (presión intraocular o PIO) puede variar, pero generalmente se considera que se encuentra entre 10 y 21 milímetros de mercurio (mmHg). Una PIO superior a lo normal se denomina hipertensión ocular y, si no se trata, puede causar daño al nervio óptico (glaucoma) y provocar una pérdida permanente de la visión.

■ **Pérdida de células endoteliales**
La córnea (la parte frontal transparente del ojo) posee una fina capa de células especiales llamadas células endoteliales. Estas células mantienen la córnea transparente eliminando el exceso de líquido. Normalmente, el número de estas células disminuye lentamente con la edad. La cirugía ocular, incluida la IPCL V2.0, puede causar una pérdida adicional de estas células. Si se pierden demasiadas células, la córnea puede volverse opaca y afectar a su visión.
Antes de la cirugía, su médico examinará sus ojos para comprobar si es un candidato adecuado para la IPCL V2.0. Después de la cirugía, puede producirse una pérdida continua de estas células con el paso del tiempo. Si se pierden demasiadas células, puede acumularse líquido en la córnea (denominado edema corneal), lo que podría requerir un trasplante de córnea.

■ **Otras complicaciones**
Otros riesgos asociados con la cirugía IPCL V2.0 pueden incluir:
- desplazamiento de la parte coloreada del ojo (iris) a través de una herida quirúrgica hacia una posición fuera del ojo (prolapso del iris),
- hemorragia en el área de la retina responsable de la visión de lectura (hemorragia macular),
- hemorragia debajo de la retina (hemorragia subretiniana),
- aumento del error de enfoque (astigmatismo),
- desprendimiento o tracción de la retina desde su posición natural (desprendimiento de retina),
- tamaño desigual de las pupilas (anisocoria).

Las reacciones adversas y complicaciones debidas a la cirugía o posteriores a ella, así como a la implantación de cualquier Lente de Contacto Fáquica Implantable, pueden incluir, entre otras:

- Aumento del astigmatismo
- Error refractivo
- Infección intraocular
- Pérdida de vítreo
- Problemas de vaulting
- Catarata subcapsular anterior
- Inflamación intraocular grave
- Glaucoma
- Glaucoma secundario
- Uveítis
- Vitritis
- Hifema
- Hipopión
- Corrección insuficiente/excesiva
- Pupila no reactiva
- Endoftalmitis
- TASS (Síndrome tóxico del segmento anterior)
- Desprendimiento de retina
- Iritis
- Edema macular quístico
- Edema macular
- Descompensación corneal
- Edema corneal
- Bloqueo pupilar
- Captura del iris
- PIO >5 mmHg por encima del valor basal y PIO >25 mmHg

BACK

- Implantation of an IPCL V2.0 may result in a decrease in corneal endothelial Cell density

Contraindications and Warnings

- Implantable Phakic Contact Lens (IPCL V2.0) is contraindicated in the presence of any of the following circumstances and/or conditions but not limited to the following: Patients with a history of/or clinical signs of iritis, uveitis, synechiae, pigment dispersion syndrome, retinal disease (other than manifestation of myopic degeneration), chronic intraocular inflammation, macular degeneration, irregular astigmatism, keratoconus or cystoid macular edema in either eye
- Patients with diabetic retinopathy in either eye
- Patients with glaucoma in either eye
- Patients with history of previous intraocular surgery (including refractive surgery) in the eye to be
- treated
- Patients who are amblyopic or blind in the fellow eye
- Patients who do not fall in the range of pretreatment myopia and/or astigmatism as outlined in this
- clinical protocol inclusion criteria
- Patients with a progressive sight-threatening disease. Patients with retinal findings associated with
- pathological myopia are allowed
- Patients with a diagnosis of ocular hypertension
- Patients with insulin-dependent diabetes
- Patients with Fuch's dystrophy or other corneal pathology
- Patients with cataract in either eye
- Patients with an unstable refraction in the past 12 months (myopia and/or astigmatism)
- Patients who are pregnant or nursing
- Patients with low/abnormal corneal endothelial cell density
- Patients with Anterior chamber depth <2.8mm

Are You A Good Candidate For IPCL V2.0 Surgery?

Your doctor will perform a detailed eye check-up to see if IPCL V2.0 surgery is suitable for you. You may be considered for this surgery if you:

- are 21 to 45 years old (for Monofocal and Toric lenses) or 40 to 60 years old (for presbyopic lenses)
- have nearsightedness between –0.5 D to –15 D or farsightedness between +0.5 D to +15 D (for IPCL V2.0 Monofocal and IPCL V2.0 Toric) and astigmatism between +1.0 D and +10 D (for IPCL V2.0 Presbyopic and IPCL V2.0 Presbyopic Toric)
- have astigmatism (for toric lenses), if applicable
- have enough space inside your eye to safely place the lens
- have a minimally acceptable density of the thin, single layer of cells (endothelial cells) on the innermost surface of the cornea, responsible for keeping the cornea clear. If your doctor determines that your endothelial cell density is below the minimum level, you will be at greater risk of swelling of your cornea (corneal edema), possibly requiring removal and replacement of your cornea (corneal transplantation)
- have written evidence that your nearsightedness or farsightedness has been stable for at least 1 year;
- understand the benefits and risks of the surgery and compared to other treatment options
- have no known allergies to any of the medications that your doctor may discuss will be used before, during and after your surgery
- are not pregnant or breastfeeding
- understand that at between 2 to 3 weeks before IPCL V2.0 surgery you will need to have holes made in the extreme outer edge of the colored portion of the eye (peripheral iridotomy) using a laser
- are willing to sign a consent form before the procedure

You and your doctor will determine if you are a suitable candidate for the IPCL V2.0 (monofocal, toric, presbyopic and presbyopic toric) and the frequency of follow-up required to monitor the health of your eye.

What Should You Expect During IPCL V2.0 Surgery?

Before the Surgery

Before surgery, your doctor will review your medical and eye history and examine both eyes to make sure they are healthy and suitable for IPCL V2.0. This includes checking the inner layer of your cornea (endothelium). If you wear contact lenses, stop using them 2 to 4 weeks before your eye check-up and surgery. This helps your doctor get accurate measurements. Not doing this may affect your results.

Tell your doctor about any medicines you take, eye problems, past eye surgeries, medical conditions, or allergies. Ask if you should eat or drink before surgery. Also, arrange for someone to take you home, as you should not drive right after the procedure. Your doctor will tell you when it is safe to drive again.

Two to Three Weeks before Surgery

Two to three weeks before your IPCL V2.0 surgery, your doctor will make two holes in the extreme outer edge of the colored portion of the eye (peripheral iridotomies) to prepare your eye for implantation of the IPCL V2.0 . This is necessary to make sure that the fluid flows properly from the back chamber to the front chamber of the eye to prevent a buildup of pressure within the eye after IPCL V2.0 surgery. The doctor will usually apply numbing drops to the eye and make tiny openings in the colored portion of the eye (iris) with a laser beam. Usually this doesn't affect your ability to drive home after this procedure but check with your doctor.

After the peripheral iridotomy procedure, you will be prescribed eye drops for you to use. It is important that you follow all medication instructions. Your doctor will instruct you to discontinue the use of these medications before the day of surgery.

The Day of Surgery

On the day of surgery, eye drops will be placed in your eye to enlarge (dilate) the black part of your eye (pupil). Once your pupil is fully dilated, your doctor will put numbing eye drops in your eye and/or inject a needle with numbing medication into your eye and ask you to lie on your back on the treatment table/chair in the treatment room. Your doctor may discuss different options for numbing or relaxing you before the surgery. A small cut is made in the cornea (the clear front part of the eye), and the IPCL V2.0 lens is placed in the correct position inside your eye. The procedure usually takes about 20 to 30 minutes.

After the surgery, your doctor will apply eye drops or ointment and may cover your eye with a patch or shield for protection. The procedure is painless due to the numbing medicine. Do not drive yourself home after surgery. Please arrange for someone to take you home in advance.

The First Day after Surgery

Your doctor will check your eye the day after surgery, including measuring the pressure in your eye. You may feel sensitive to light or feel like something is in your eye. Wearing sunglasses can help. Some discomfort or mild pain is normal, and your doctor may give you medicine to help. If you have severe pain, contact your doctor immediately. You will need to use eye drops or ointment for about a week to prevent infection and reduce inflammation.

IMPORTANT: Use the eye medications as directed by your eye doctor. (Your results may depend upon you following your doctor's instructions).

DO NOT rub your eyes, especially for the first 3 to 5 days after surgery. If you notice any sudden decrease in your vision, you should contact your doctor immediately.

Long Term Care: In some cases, the IPCL V2.0 may need to be replaced or removed. It may be replaced if another lens is better suited for your eye or can give you better vision. It may be removed if you develop a cataract and need cataract surgery In such cases, a new lens can be implanted to help correct your vision.

If the IPCL V2.0 is removed, you will lose the vision correction it provided, and your vision may not be the same as before surgery. It is important to follow your doctor's advice and attend all follow-up visits after surgery.

Questions To Ask Your Doctor

You may want to ask the following questions to help you decide if IPCL V2.0 surgery for nearsightedness or farsightedness is right for you:

- What other options do I have to correct my nearsightedness or farsightedness?
- Will I have to limit my activities after surgery and for how long?
- What are the benefits of IPCL V2.0 surgery for my amount of nearsightedness and farsightedness?
- How will my vision be in the first few months after surgery?
- If IPCL V2.0 surgery does not correct my vision, what is the possibility that my eyeglasses would need to be stronger than before? Could my need for eyeglasses increase over time? Could I undergo a different type of eye surgery for the correction of my vision?
- How is IPCL V2.0 surgery likely to affect my need to wear eyeglasses or contact lenses as I get older?
- Will my eye heal differently, if injured after implantation of the IPCL V2.0?
- Should I have IPCL V2.0 surgery in my other eye?
- How long will I have to wait before I can have surgery in my other eye?
- What vision problems might I experience if I have IPCL V2.0 only in 1 eye?

Summary of Important Information

- IPCL V2.0 Surgery provides a permanent correction of your nearsightedness or farsightedness as long as the IPCL V2.0 remains in the eye. The IPCL V2.0 may be removed. If it is removed, you will lose this benefit, and your vision may not be the same as before surgery.
- IPCL V2.0 surgery does not eliminate the need for reading glasses, even if you have never worn them before.
- Your vision must be stable before IPCL V2.0 surgery. You must provide written evidence that your nearsightedness or farsightedness has changed by no more than 0.50 D each year for at least 1 year.
- If you are pregnant or breastfeeding, you should wait before having this surgery.
- Like all surgeries, IPCL V2.0 has risks. It is important to read and understand all the information before deciding.
- Other options to correct your vision include glasses, contact lenses, and surgeries like RK, PRK, and LASIK.
- Before considering IPCL V2.0 surgery you should:
  a. have a complete eye examination.
  b. talk with at least one eye care professional about IPCL V2.0 surgery, especially the potential benefits, risks, and complications. You should discuss the time needed for healing after surgery.

Magnetic Resonance Compatibility:

The implanted IOL does not contain any metallic components and is safe with no potential for interaction with the Magnetic Resonance (MR) Field. IOL is safer for Magnet Resonance Imaging (MRI) at a magnetic field strength of 1.5 and 3.0 Tesla.

Expected lifetime and necessary follow-up

The IOL will usually last for a patient's lifetime. Should you however encounter any deterioration in your vision quality, please consult your eye doctor for further investigation and treatment. Your eye doctor will discuss with you about the necessary follow-up intervals based on your medical condition.

Reporting of serious incidents

Any serious incident that occurs in relation to the intraocular lens should be reported to your doctor (in the first instance), to the local representative or to the EYEOL U.K. LIMITED.

About this document:

Your eye doctor has performed the refractive surgery and implanted the intraocular lens (IOL) in your eye. The patient implant card and leaflet have been given to you after the surgery. Please always carry the patient implant card with you to facilitate medical care in case of emergency. The link provided on the implant card will provide you latest updates about the IOL.

MFG/MD/2020/000163
EYEOL U.K. LIMITED
8 Apex Business Centre, Boscombe Road,
Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, UK
Tel: +44 (0) 1582 477 002
Fax: +44 (0) 1582 607 009
Email: info@eyeol.co.uk
Web: www.eyeol.co.uk

EU REP **European Representative**
OBELIS S.A
Bd. General Wahis, 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +32.2.732,59.54
Fax:+32.2.732.60.03
Email:mail@obelis.net
Web:www.obelis.net

CE
2460

- Décompensation cornéenne
- Œdème cornéen
- Bloc pupillaire
- Capture de l'iris
- PIO > 5 mmHg au-dessus de la valeur de référence et PIO > 25 mmHg
- Éblouissements importants et/ou halos autour des lumières
- Décentrement/rotation de l'IPCL V2.0
- Perte de cellules endothéliales cornéennes
- Luxation/rotation de l'IPCL V2.0
- Perte de la meilleure acuité visuelle corrigée par lunettes
- Intervention chirurgicale secondaire pour retirer/remplacer l'IPCL V2.0
- L'implantation d'une IPCL V2.0 peut entraîner une diminution de la densité des cellules endothéliales cornéennes.

Contre-indications et avertissements

- La lentille de contact phake implantable (IPCL V2.0) est contre-indiquée en présence de l'une des circonstances et/ou affections suivantes, sans s'y limiter : patients ayant des antécédents ou des signes cliniques d'iritis, d'uvéite, de synéchies, de syndrome de dispersion pigmentaire, de maladie rétinienne (autre que les manifestations de dégénérescence myopique), d'inflammation intraoculaire chronique, de dégénérescence maculaire, d'astigmatisme irrégulier, de kératocône ou d'œdème maculaire cystoïde dans l'un ou l'autre œil.
- Patients atteints de rétinopathie diabétique dans l'un ou l'autre œil.
- Patients atteints de glaucome dans l'un ou l'autre œil.
- Patients ayant des antécédents de chirurgie intraoculaire antérieure (y compris chirurgie réfractive) dans l'œil à traiter.
- Patients présentant une amblyopie ou une cécité de l'œil controlatéral.
- Patients ne correspondant pas aux plages de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définies dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie évolutive menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétiniennes associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hypertension oculaire.
- Patients atteints de diabète insulinodépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteints de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable au cours des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patientes enceintes ou allaitantes.
- Patients présentant une faible densité ou une densité anormale des cellules endothéliales cornéennes.
- Patients présentant une profondeur de chambre antérieure inférieure à 2,8 mm.

Êtes-vous un bon candidat pour la chirurgie IPCL V2.0 ?

Votre médecin réalisera un examen ophtalmologique approfondi afin de déterminer si la chirurgie IPCL V2.0 vous convient. Vous pouvez être considéré comme candidat à cette intervention si vous :

- êtes âgé de 21 à 45 ans (pour les lentilles monofocales et toriques) ou de 40 à 60 ans (pour les lentilles presbyopiques) ;
- présentez une myopie comprise entre –0,5 D et –15 D ou une hypermétropie comprise entre +0,5 D et +15 D (pour l'IPCL V2.0 Monofocale et l'IPCL V2.0 Torique), ainsi qu'un astigmatisme compris entre +1,0 D et +10 D (pour l'IPCL V2.0 Presbyopique et l'IPCL V2.0 Presbyopique Torique) ;
- présentez un astigmatisme (pour les lentilles toriques), le cas échéant ;
- disposez d'un espace suffisant à l'intérieur de l'œil pour permettre l'implantation sûre de la lentille ;
- possédez une densité minimale acceptable de la fine couche unique de cellules (cellules endothéliales) située sur la surface la plus interne de la cornée, responsable du maintien de sa transparence. Si votre médecin détermine que votre densité cellulaire endothéliale est inférieure au niveau minimal requis, vous présenterez un risque accru de gonflement de la cornée (œdème cornéen), pouvant nécessiter l'ablation et le remplacement de votre cornée (transplantation cornéenne) ;
- disposez d'une preuve écrite démontrant que votre myopie ou votre hypermétropie est stable depuis au moins un an ;
- comprenez les avantages et les risques de l'intervention ainsi que leur comparaison avec les autres options thérapeutiques ;
- ne présentez aucune allergie connue aux médicaments que votre médecin prévoit d'utiliser avant, pendant ou après l'intervention ;
- n'êtes pas enceinte et n'allaitez pas ;
- comprenez qu'entre 2 et 3 semaines avant la chirurgie IPCL V2.0, il sera nécessaire de réaliser des ouvertures dans la périphérie extrême de la partie colorée de l'œil (iridotomie périphérique) à l'aide d'un laser ;
- acceptez de signer un formulaire de consentement avant l'intervention.

Vous et votre médecin déterminerez si vous êtes un candidat approprié pour l'IPCL V2.0 (monofocale, torique, presbyopique ou presbyopique torique) ainsi que la fréquence des consultations de suivi nécessaires pour surveiller la santé de votre œil.

À quoi devez-vous vous attendre pendant la chirurgie IPCL V2.0 ?

Avant l'intervention

Avant l'intervention, votre médecin examinera vos antécédents médicaux et ophtalmologiques et procédera à un examen de vos deux yeux afin de s'assurer qu'ils sont sains et adaptés à l'implantation d'une IPCL V2.0. Cet examen comprend notamment l'évaluation de la couche interne de votre cornée (endothélium).Si vous portez des lentilles de contact, vous devez arrêter de les utiliser 2 à 4 semaines avant votre examen ophtalmologique et votre intervention. Cela permet à votre médecin d'obtenir des mesures précises. Le non-respect de cette consigne peut affecter vos résultats.

Informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, de tout problème oculaire, de toute intervention chirurgicale oculaire antérieure, de vos antécédents médicaux ou de vos allergies. Demandez à votre médecin si vous pouvez manger ou boire avant l'intervention. Prévoyez également qu'une autre personne vous raccompagne chez vous, car vous ne devez pas conduire immédiatement après l'intervention. Votre médecin vous indiquera à quel moment vous pourrez reprendre la conduite en toute sécurité.

Deux à trois semaines avant l'intervention

Deux à trois semaines avant votre chirurgie IPCL V2.0, votre médecin réalisera deux ouvertures dans la périphérie extrême de la partie colorée de l'œil (iridotomies périphériques) afin de préparer votre œil à l'implantation de l'IPCL V2.0. Cette procédure est nécessaire pour assurer une bonne circulation du liquide entre la chambre postérieure et la chambre antérieure de l'œil et ainsi prévenir une augmentation de la pression intraoculaire après la chirurgie IPCL V2.0.
Le médecin applique généralement des gouttes anesthésiantes dans l'œil puis crée de petites ouvertures dans la partie colorée de l'œil (iris) à l'aide d'un faisceau laser. Cette procédure n'affecte généralement pas votre capacité à rentrer chez vous en voiture, mais il est recommandé de vérifier ce point avec votre médecin.
Après l'iridotomie périphérique, des collyres vous seront prescrits. Il est important de suivre toutes les instructions relatives aux médicaments. Votre médecin vous indiquera quand arrêter leur utilisation avant le jour de l'intervention.

Le jour de l'intervention

Le jour de l'intervention, des gouttes ophtalmiques seront instillées dans votre œil afin de dilater la partie noire de l'œil (la pupille). Une fois la pupille complètement dilatée, votre médecin appliquera des gouttes anesthésiantes et/ou réalisera une injection anesthésique dans votre œil, puis vous demandera de vous allonger sur le dos sur la table ou le fauteuil de traitement.
Votre médecin pourra discuter avec vous des différentes options d'anesthésie ou de relaxation avant l'intervention. Une petite incision est pratiquée dans la cornée (la partie transparente située à l'avant de l'œil), puis la lentille IPCL V2.0 est placée dans la position appropriée à l'intérieur de l'œil. L'intervention dure généralement entre 20 et 30 minutes.

Après l'intervention, votre médecin appliquera des collyres ou une pommade ophtalmique et pourra recouvrir votre œil d'un pansement ou d'une coque de protection. Grâce à l'anesthésie, l'intervention est indolore. Ne conduisez pas pour rentrer chez vous après l'opération. Veuillez prévoir à l'avance qu'une autre personne vous accompagne.

Le premier jour après l'intervention

Votre médecin examinera votre œil le lendemain de l'intervention, notamment en mesurant la pression intraoculaire. Vous pourrez ressentir une sensibilité à la lumière ou avoir l'impression qu'un corps étranger se trouve dans votre œil. Le port de lunettes de soleil peut être utile. Une certaine gêne ou une douleur légère est normale, et votre médecin pourra vous prescrire un traitement pour vous soulager. Si vous ressentez une douleur importante, contactez immédiatement votre médecin.
Vous devrez utiliser des collyres ou une pommade ophtalmique pendant environ une semaine afin de prévenir les infections et de réduire l'inflammation.

IMPORTANT : Utilisez les médicaments ophtalmiques conformément aux instructions de votre ophtalmologiste. (Vos résultats peuvent dépendre du respect des instructions de votre médecin.)

NE vous frottez PAS les yeux, en particulier pendant les 3 à 5 premiers jours suivant l'intervention. Si vous constatez une diminution soudaine de votre vision, vous devez contacter immédiatement votre médecin.

Suivi à long terme : Dans certains cas, l'IPCL V2.0 peut devoir être remplacée ou retirée. Elle peut être remplacée si une autre lentille est mieux adaptée à votre œil ou peut vous offrir une meilleure vision. Elle peut être retirée si vous développez une cataracte nécessitant une chirurgie de la cataracte. Dans ce cas, une nouvelle lentille peut être implantée afin de contribuer à corriger votre vision.

Si l'IPCL V2.0 est retirée, vous perdrez la correction visuelle qu'elle procurait et votre vision pourrait ne plus être identique à celle obtenue après l'intervention. Il est important de suivre les recommandations de votre médecin et d'assister à toutes les visites de suivi après l'intervention.

Questions à poser à votre médecin

Vous pouvez souhaiter poser les questions suivantes afin de vous aider à déterminer si la chirurgie IPCL V2.0 pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie vous convient :

- Quelles autres options ai-je pour corriger ma myopie ou mon hypermétropie ?
- Devrai-je limiter mes activités après l'intervention et pendant combien de temps ?
- Quels sont les avantages de la chirurgie IPCL V2.0 pour mon degré de myopie ou d'hypermétropie ?
- Comment sera ma vision au cours des premiers mois suivant l'intervention ?
- Si la chirurgie IPCL V2.0 ne corrige pas ma vision de manière satisfaisante, est-il possible que mes lunettes nécessitent une correction plus forte qu'auparavant ? Mon besoin de porter des lunettes pourrait-il augmenter avec le temps ? Pourrais-je bénéficier d'un autre type de chirurgie oculaire pour corriger ma vision ?
- Comment la chirurgie IPCL V2.0 est-elle susceptible d'influencer mon besoin de porter des lunettes ou des lentilles de contact en vieillissant ?
- Mon œil cicatrisera-t-il différemment en cas de blessure après l'implantation de l'IPCL V2.0 ?
- Devrais-je subir une chirurgie IPCL V2.0 dans mon autre œil ?
- Combien de temps devrai-je attendre avant de pouvoir faire opérer mon autre œil ?
- Quels problèmes visuels pourrais-je rencontrer si je ne reçois une IPCL V2.0 que dans un seul œil ?

Résumé des informations importantes

- La chirurgie IPCL V2.0 procure une correction permanente de votre myopie ou de votre hypermétropie tant que l'IPCL V2.0 demeure dans l'œil. L'IPCL V2.0 peut toutefois être retirée. Si elle est retirée, vous perdrez ce bénéfice et votre vision pourrait ne plus être identique à celle obtenue après l'intervention.
- La chirurgie IPCL V2.0 n'élimine pas le besoin de porter des lunettes de lecture, même si vous n'en avez jamais porté auparavant.
- Votre vision doit être stable avant la chirurgie IPCL V2.0. Vous devez fournir une preuve écrite démontrant que votre myopie ou votre hypermétropie n'a pas varié de plus de 0,50 D par an pendant au moins un an.
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, vous devez attendre avant de subir cette intervention.
- Comme toute intervention chirurgicale, l'IPCL V2.0 comporte des risques. Il est important de lire et de comprendre toutes les informations avant de prendre votre décision.
- Les autres options pour corriger votre vision comprennent les lunettes, les lentilles de contact et des interventions chirurgicales telles que la RK, la PRK et le LASIK.
- Avant d'envisager une chirurgie IPCL V2.0, vous devez :
  a. subir un examen ophtalmologique complet.
  b. consulter au moins un professionnel de la santé visuelle au sujet de la chirurgie IPCL V2.0, en particulier concernant les bénéfices potentiels, les risques et les complications. Vous devez également discuter du temps de récupération nécessaire après l'intervention chirurgicale.

Compatibilité avec la résonance magnétique

La LIO implantée ne contient aucun composant métallique et ne présente aucun risque dInteraction avec le champ de résonance magnétique (RM). La LIO est compatible avec l'imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée à des intensités de champ magnétique de 1,5 et 3,0 Tesla.

Durée de vie attendue et suivi nécessaire

La LIO est généralement conçue pour durer toute la vie du patient. Toutefois, si vous constatez une détérioration de la qualité de votre vision, veuillez consulter votre ophtalmologiste afin de procéder à des examens complémentaires et à un traitement approprié. Votre ophtalmologiste discutera avec vous de la fréquence des consultations de suivi nécessaires en fonction de votre état de santé.

Déclaration des incidents graves

Tout incident grave survenant en lien avec la lentille intraoculaire doit être signalé à votre médecin (en premier lieu), au représentant local ou à EYEOL U.K. LIMITED.

À propos de ce document :

Votre ophtalmologiste a réalisé la chirurgie réfractive et a implanté la lentille intraoculaire (LIO) dans votre œil. La carte d'implant du patient ainsi que cette notice vous ont été remises après l'intervention. Veuillez toujours conserver la carte d'implant du patient sur vous afin de faciliter la prise en charge médicale en cas d'urgence. Le lien indiqué sur la carte d'implant vous permettra d'accéder aux dernières mises à jour concernant la LIO.

MFG/MD/2020/000163
EYEOL U.K. LIMITED
8 Apex Business Centre, Boscombe Road,
Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 1582 477 002
Fax : +44 (0) 1582 607 009
Email : info@eyeol.co.uk
Site web : www.eyeol.co.uk

EU REP **Représentant européen**
OBELIS S.A
Bd. Général Wahis, 53
1030 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32.2.732.59.54
Fax : +32.2.732.60.03
Email : mail@obelis.net
Site web : www.obelis.net

CE
2460

DE

- Augeninnendruck > 5 mmHg über dem Ausgangswert und Augeninnendruck > 25 mmHg
- Erhebliche Blendungen und/oder Halos um Lichtquellen
- Dezentrierung/Drehung der IPCL V2.0
- Verlust von Hornhaut-Endothelzellen
- Linsendislokation/Drehung der IPCL V2.0
- Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe mit Brille
- Sekundärer chirurgischer Eingriff zur Entfernung/zum Austausch der IPCL V2.0
- Die Implantation einer IPCL V2.0 kann zu einer Verringerung der Dichte der Hornhaut-Endothelzellen führen.

Kontraindikationen und Warnhinweise

- Die implantierbare phake Kontaktlinse (IPCL V2.0) ist bei Vorliegen einer der folgenden Umstände und/oder Erkrankungen kontraindiziert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Patienten mit einer Vorgeschichte von oder klinischen Anzeichen für Iritis, Uveitis, Synechien, Pigmentdispersionssyndrom, Netzhauterkrankungen (außer Manifestationen einer myopischen Degeneration), chronischer intraokularer Entzündung, Makuladegeneration, irregulärem Astigmatismus, Keratokonus oder zystoidem Makulaödem in einem der Augen.
- Patienten mit diabetischer Retinopathie in einem der Augen.
- Patienten mit Glaukom in einem der Augen.
- Patienten mit vorausgegangenen intraokularen Operationen (einschließlich refraktiver Chirurgie) am zu behandelnden Auge.
- Patienten mit Amblyopie oder Blindheit des Partnerauges.
- Patienten, deren Myopie und/oder Astigmatismus nicht innerhalb der in diesem klinischen Protokoll festgelegten Einschlusskriterien liegt.
- Patienten mit einer fortschreitenden, das Sehvermögen bedrohenden Erkrankung. Patienten mit Netzhautbefunden im Zusammenhang mit pathologischer Myopie sind zulässig.
- Patienten mit diagnostizierter okulärer Hypertonie.
- Patienten mit insulinabhängigem Diabetes.
- Patienten mit Fuchs-Endotheldystrophie oder anderen Hornhauterkrankungen.
- Patienten mit Katarakt in einem der Augen.
- Patienten mit instabiler Refraktion in den letzten 12 Monaten (Myopie und/oder Astigmatismus).
- Patientinnen, die schwanger sind oder stillen.
- Patienten mit niedriger oder abnormaler Dichte der Hornhaut-Endothelzellen.
- Patienten mit einer Vorderkammertiefe von < 2,8 mm.
-

Sind Sie ein geeigneter Kandidat für eine IPCL V2.0-Operation?

Ihr Arzt wird eine ausführliche Augenuntersuchung durchführen, um festzustellen, ob eine IPCL V2.0-Operation für Sie geeignet ist. Sie kommen möglicherweise für diesen Eingriff infrage, wenn Sie:

- zwischen 21 und 45 Jahre alt sind (für monofokale und torische Linsen) oder zwischen 40 und 60 Jahre alt sind (für presbyope Linsen),
- eine Kurzsichtigkeit zwischen –0,5 D und –15 D oder eine Weitsichtigkeit zwischen +0,5 D und +15 D aufweisen (für IPCL V2.0 Monofocal und IPCL V2.0 Toric) sowie einen Astigmatismus zwischen +1,0 D und +10 D (für IPCL V2.0 Presbyopic und IPCL V2.0 Presbyopic Toric),
- gegebenenfalls an Astigmatismus leiden (für torische Linsen),
- ausreichend Platz im Auge haben, um die Linse sicher zu implantieren,
- eine mindestens akzeptable Dichte der dünnen, einschichtigen Zellschicht (Endothelzellen) auf der innersten Oberfläche der Hornhaut besitzen, die für die Aufrechterhaltung der Hornhautklarheit verantwortlich ist. Wenn Ihr Arzt feststellt, dass Ihre Endothelzelldichte unter dem Mindestwert liegt, besteht ein erhöhtes Risiko für eine Hornhautschwellung (Hornhautödem), die möglicherweise die Entfernung und den Ersatz der Hornhaut (Hornhauttransplantation) erforderlich macht,
- schriftlich nachweisen können, dass Ihre Kurz- oder Weitsichtigkeit seit mindestens einem Jahr stabil ist,
- die Vorteile und Risiken der Operation sowie den Vergleich mit anderen Behandlungsmöglichkeiten verstehen,
- keine bekannten Allergien gegen Medikamente haben, die Ihr Arzt vor, während oder nach der Operation anwenden könnte,
- nicht schwanger sind und nicht stillen,
- verstehen, dass etwa 2 bis 3 Wochen vor der IPCL V2.0-Operation mittels Laser kleine Öffnungen am äußersten Rand des farbigen Teils des Auges (periphere Iridotomie) angelegt werden müssen,
- bereit sind, vor dem Eingriff eine Einverständniserklärung zu unterzeichnen.

Sie und Ihr Arzt werden gemeinsam entscheiden, ob Sie ein geeigneter Kandidat für die IPCL V2.0 (monofokal, torisch, presbyop und presbyop-torisch) sind und in welchen Abständen Nachsorgeuntersuchungen erforderlich sind, um die Gesundheit Ihres Auges zu überwachen.

Was können Sie während einer IPCL V2.0-Operation erwarten?

Vor der Operation

Vor der Operation wird Ihr Arzt Ihre medizinische und augenärztliche Vorgeschichte prüfen und beide Augen untersuchen, um sicherzustellen, dass sie gesund und für die Implantation einer IPCL V2.0 geeignet sind. Dazu gehört auch die Untersuchung der inneren Schicht Ihrer Hornhaut (Endothel). Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, sollten Sie deren Verwendung 2 bis 4 Wochen vor Ihrer Augenuntersuchung und der Operation einstellen. Dies hilft Ihrem Arzt, genaue Messwerte zu erhalten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Ihre Ergebnisse beeinflussen.

Informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente, die Sie einnehmen, über Augenprobleme, frühere Augenoperationen, bestehende Erkrankungen oder Allergien. Fragen Sie Ihren Arzt, ob Sie vor der Operation essen oder trinken dürfen. Organisieren Sie außerdem eine Begleitperson für die Heimfahrt, da Sie unmittelbar nach dem Eingriff nicht selbst fahren sollten. Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, wann Sie wieder sicher ein Fahrzeug führen dürfen.

Zwei bis drei Wochen vor der Operation

Zwei bis drei Wochen vor Ihrer IPCL V2.0-Operation wird Ihr Arzt zwei kleine Öffnungen am äußersten Rand des farbigen Teils Ihres Auges (periphere Iridotomien) anlegen, um Ihr Auge auf die Implantation der IPCL V2.0 vorzubereiten. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Augenflüssigkeit ordnungsgemäß von der hinteren Augenkammer in die vordere Augenkammer fließen kann und um einen Druckanstieg im Auge nach der IPCL V2.0-Operation zu verhindern.
Der Arzt wird in der Regel betäubende Augentropfen anwenden und mithilfe eines Laserstrahls kleine Öffnungen in der Iris erzeugen. Normalerweise beeinträchtigt dieser Eingriff nicht Ihre Fähigkeit, anschließend selbst nach Hause zu fahren. Bitte klären Sie dies jedoch mit Ihrem Arzt.
Nach der peripheren Iridotomie werden Ihnen Augentropfen verschrieben. Es ist wichtig, dass Sie alle Anweisungen zur Anwendung der Medikamente befolgen. Ihr Arzt wird Sie darüber informieren, wann Sie die Anwendung dieser Medikamente vor dem Operationstag beenden sollen.

Am Tag der Operation

Am Tag der Operation werden Augentropfen in Ihr Auge gegeben, um den schwarzen Teil Ihres Auges (die Pupille) zu erweitern (zu dilatieren). Sobald Ihre Pupille vollständig erweitert ist, wird Ihr Arzt betäubende Augentropfen verabreichen und/oder ein Betäubungsmittel mittels Injektion in Ihr Auge einbringen und Sie bitten, sich auf dem Behandlungstisch bzw. Behandlungsstuhl im Operationsraum auf den Rücken zu legen.
Vor der Operation kann Ihr Arzt verschiedene Möglichkeiten zur Betäubung oder Beruhigung mit Ihnen besprechen. Anschließend wird ein kleiner Schnitt in die Hornhaut (den klaren vorderen Teil des Auges) gesetzt, und die IPCL V2.0-Linse wird in die korrekte Position im Auge eingesetzt. Der Eingriff dauert in der Regel etwa 20 bis 30 Minuten.

Nach der Operation wird Ihr Arzt Augentropfen oder eine Augensalbe anwenden und Ihr Auge möglicherweise mit einem Verband oder einer Schutzschale abdecken. Dank der Betäubung ist der Eingriff schmerzfrei. Fahren Sie nach der Operation nicht selbst nach Hause. Bitte organisieren Sie im Voraus eine Person, die Sie nach Hause begleitet.

Der erste Tag nach der Operation

Ihr Arzt wird Ihr Auge am Tag nach der Operation untersuchen, einschließlich der Messung des Augeninnendrucks. Möglicherweise sind Sie lichtempfindlich oder haben das Gefühl, dass sich etwas in Ihrem Auge befindet. Das Tragen einer Sonnenbrille kann hilfreich sein. Leichte Beschwerden oder geringe Schmerzen sind normal, und Ihr Arzt kann Ihnen Medikamente zur Linderung verschreiben. Wenn Sie starke Schmerzen haben, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt. Sie müssen etwa eine Woche lang Augentropfen oder eine Augensalbe anwenden, um Infektionen vorzubeugen und Entzündungen zu reduzieren.

WICHTIG: Verwenden Sie die Augenmedikamente genau nach Anweisung Ihres Augenarztes. (Der Erfolg der Behandlung kann davon abhängen, dass Sie die Anweisungen Ihres Arztes befolgen.)

Reiben Sie Ihre Augen **NICHT**, insbesondere in den ersten 3 bis 5 Tagen nach der Operation. Wenn Sie eine plötzliche Verschlechterung Ihres Sehvermögens bemerken, sollten Sie unverzüglich Ihren Arzt kontaktieren.

Langfristige Nachsorge:

In einigen Fällen muss die IPCL V2.0 ersetzt oder entfernt werden. Sie kann ersetzt werden, wenn eine andere Linse besser für Ihr Auge geeignet ist oder ein besseres Sehvermögen ermöglicht. Sie kann entfernt werden, wenn sich ein Katarakt entwickelt und eine Kataraktoperation erforderlich wird. In solchen Fällen kann eine neue Linse implantiert werden, um Ihr Sehvermögen zu korrigieren.

Wird die IPCL V2.0 entfernt, verlieren Sie die durch sie erzielte Sehkorrektur, und Ihr Sehvermögen entspricht möglicherweise nicht mehr dem Zustand nach der Operation. Es ist wichtig, die Anweisungen Ihres Arztes zu befolgen und alle Nachsorgetermine nach der Operation wahrzunehmen.

Fragen, die Sie Ihrem Arzt stellen können

Möglicherweise möchten Sie die folgenden Fragen stellen, um zu entscheiden, ob eine IPCL V2.0-Operation zur Korrektur Ihrer Kurz- oder Weitsichtigkeit für Sie geeignet ist:

- Welche anderen Möglichkeiten habe ich zur Korrektur meiner Kurz- oder Weitsichtigkeit?
- Muss ich meine Aktivitäten nach der Operation einschränken, und wenn ja, für wie lange?
- Welche Vorteile bietet die IPCL V2.0-Operation bei meinem Grad an Kurz- oder Weitsichtigkeit?
- Wie wird mein Sehvermögen in den ersten Monaten nach der Operation sein?
- Falls die IPCL V2.0-Operation mein Sehvermögen nicht ausreichend korrigiert, wie wahrscheinlich ist es, dass ich stärkere Brillengläser als zuvor benötige? Könnte mein Bedarf an Brillen im Laufe der Zeit zunehmen? Könnte ich mich einer anderen Art von Augenoperation zur Sehkorrektur unterziehen?
- Wie wird sich die IPCL V2.0-Operation voraussichtlich auf meinen Bedarf an Brillen oder Kontaktlinsen im Alter auswirken?
- Wird mein Auge nach einer Verletzung anders heilen, wenn eine IPCL V2.0 implantiert wurde?
- Sollte ich auch an meinem anderen Auge eine IPCL V2.0-Operation durchführen lassen?
- Wie lange muss ich warten, bevor ich mein anderes Auge operieren lassen kann?
- Welche Sehprobleme könnten auftreten, wenn ich die IPCL V2.0 nur in einem Auge implantiert bekomme?

Zusammenfassung wichtiger Informationen

- Die IPCL V2.0-Operation bietet eine dauerhafte Korrektur Ihrer Kurz- oder Weitsichtigkeit, solange die IPCL V2.0 im Auge verbleibt. Die IPCL V2.0 kann entfernt werden. Wird sie entfernt, geht dieser Vorteil verloren, und Ihr Sehvermögen entspricht möglicherweise nicht mehr dem Zustand vor der Operation.
- Die IPCL V2.0-Operation beseitigt nicht die Notwendigkeit einer Lesebrille, selbst wenn Sie zuvor nie eine benötigt haben.
- Ihr Sehvermögen muss vor einer IPCL V2.0-Operation stabil sein. Sie müssen schriftlich nachweisen, dass sich Ihre Kurz- oder Weitsichtigkeit über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr um nicht mehr als 0,50 D pro Jahr verändert hat.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, sollten Sie mit dieser Operation warten.
- Wie jede Operation ist auch die IPCL V2.0 mit Risiken verbunden. Es ist wichtig, alle Informationen vor Ihrer Entscheidung sorgfältig zu lesen und zu verstehen.
- Weitere Möglichkeiten zur Korrektur Ihres Sehvermögens umfassen Brillen, Kontaktlinsen sowie chirurgische Verfahren wie RK, PRK und LASIK.
- Bevor Sie eine IPCL V2.0-Operation in Betracht ziehen, sollten Sie:
  a. eine vollständige Augenuntersuchung durchführen lassen.
  b. mit mindestens einem augenmedizinischen Facharzt oder einer anderen augenmedizinischen Fachkraft über die IPCL V2.0-Operation sprechen, insbesondere über die möglichen Vorteile, Risiken und Komplikationen. Sie sollten außerdem die für die Heilung nach der Operation erforderliche Zeit besprechen.

Magnetresonanz-Kompatibilität

Die implantierte Intraokularlinse enthält keine metallischen Bestandteile und ist sicher, da kein Risiko einer Wechselwirkung mit dem Magnetresonanzfeld (MR-Feld) besteht. Die Intraokularlinse ist für Magnetresonanztomographie (MRT) bei Magnetfeldstärken von 1,5 Tesla und 3,0 Tesla geeignet.

Erwartete Lebensdauer und erforderliche Nachsorge

Die Intraokularlinse hält in der Regel ein Leben lang. Sollten Sie jedoch eine Verschlechterung Ihrer Sehqualität feststellen, wenden Sie sich bitte zur weiteren Untersuchung und Behandlung an Ihren Augenarzt. Ihr Augenarzt wird mit Ihnen die erforderlichen Nachsorgeintervalle entsprechend Ihrem Gesundheitszustand besprechen.

Meldung schwerwiegender Vorkommnisse

Jedes schwerwiegende Vorkommnis im Zusammenhang mit der Intraokularlinse sollte Ihrem Arzt (zunächst), dem örtlichen Vertreter oder EYEOL U.K. LIMITED gemeldet werden.

Über dieses Dokument

Ihr Augenarzt hat die refraktive Operation durchgeführt und die Intraokularlinse (IOL) in Ihr Auge implantiert. Die Patienten-Implantatkarte und dieses Informationsblatt wurden Ihnen nach der Operation ausgehändigt. Bitte führen Sie die Patienten-Implantatkarte stets mit sich, um im Notfall eine angemessene medizinische Versorgung zu erleichtern. Über den auf der Implantatkarte angegebenen Link erhalten Sie die neuesten Informationen zur Intraokularlinse.

MFG/MD/2020/000163
EYEOL U.K. LIMITED
8 Apex Business Centre, Boscombe Road,
Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 (0) 1582 477 002
Fax: +44 (0) 1582 607 009
E-Mail: info@eyeol.co.uk
Web: www.eyeol.co.uk

EU REP **Europäischer Bevollmächtigter**
OBELIS S.A
Bd. Général Wahis 53
1030 Brüssel, Belgien
Tel.: +32.2.732.59.54
Fax: +32.2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net
Web: www.obelis.net

CE
2460

IT

- Abbagliamento significativo e/o aloni intorno alle luci
- Decentramento/rotazione della IPCL V2.0
- Perdita di cellule endoteliali corneali
- Dislocazione/rotazione della lente IPCL V2.0
- Perdita della migliore acuità visiva corretta con occhiali
- Intervento chirurgico secondario per rimuovere/sostituire la IPCL V2.0
- L'impianto di una IPCL V2.0 può comportare una diminuzione della densità delle cellule endoteliali corneali.
-

Controindicazioni e Avvertenze

- La Lente a Contatto Facica Impiantabile (IPCL V2.0) è controindicata in presenza di una qualsiasi delle seguenti circostanze e/o condizioni, incluse ma non limitate a: pazienti con anamnesi e/o segni clinici di irite, uveite, sinechie, sindrome da dispersione pigmentaria, malattia retinica (diversa dalle manifestazioni della degenerazione miopica), infiammazione intraoculare cronica, degenerazione maculare, astigmatismo irregolare, cheratocono o edema maculare cistoide in uno dei due occhi.
- Pazienti con retinopatia diabetica in uno dei due occhi.
- Pazienti con glaucoma in uno dei due occhi.
- Pazienti con precedenti interventi chirurgici intraoculari (compresa la chirurgia refrattiva) nell'occhio da trattare.
- Pazienti affetti da ambliopia o cecità nell'occhio controlaterale.
- Pazienti che non rientrano nei limiti di miopia e/o astigmatismo preoperatori definiti nei criteri di inclusione di questo protocollo clinico.
- Pazienti con una patologia progressiva che minaccia la vista. Sono ammessi pazienti con reperti retinici associati a miopia patologica.
- Pazienti con diagnosi di ipertensione oculare.
- Pazienti con diabete insulino-dipendente.
- Pazienti con distrofia di Fuchs o altre patologie corneali.
- Pazienti con cataratta in uno dei due occhi.
- Pazienti con refrazione instabile negli ultimi 12 mesi (miopia e/o astigmatismo).
- Pazienti in gravidanza o in allattamento.
- Pazienti con densità delle cellule endoteliali corneali bassa o anomala.
- Pazienti con profondità della camera anteriore < 2,8 mm.

Siete un buon candidato per l'intervento con IPCL V2.0?

Il vostro medico effettuerà un esame oculistico approfondito per verificare se l'intervento con IPCL V2.0 è adatto a voi. Potreste essere considerati candidati per questo intervento se:

- avete un'età compresa tra 21 e 45 anni (per le lenti Monofocali e Toriche) oppure tra 40 e 60 anni (per le lenti Presbiopiche);
- presentate una miopia compresa tra –0,5 D e –15 D oppure un'ipermetropia compresa tra +0,5 D e +15 D (per IPCL V2.0 Monofocale e IPCL V2.0 Torica) e un astigmatismo compreso tra +1,0 D e +10 D (per IPCL V2.0 Presbiopica e IPCL V2.0 Presbiopica Torica);
- presentate astigmatismo (per le lenti toriche), se applicabile;
- disponete di spazio sufficiente all'interno dell'occhio per posizionare la lente in sicurezza;
- possedete una densità minima accettabile del sottile strato di cellule (cellule endoteliali) presente sulla superficie più interna della cornea, responsabile del mantenimento della trasparenza corneale. Se il medico determina che la densità delle vostre cellule endoteliali è inferiore al livello minimo richiesto, avrete un rischio maggiore di sviluppare un edema corneale, che potrebbe richiedere la rimozione e la sostituzione della cornea (trapianto di cornea);
- disponete di una documentazione scritta che dimostri che la vostra miopia o ipermetropia è rimasta stabile per almeno 1 anno;
- comprendete i benefici e i rischi dell'intervento rispetto alle altre opzioni terapeutiche;
- non avete allergie note a nessuno dei farmaci che il medico potrebbe utilizzare prima, durante e dopo l'intervento;
- non siete in gravidanza né state allattando;
- comprendete che tra 2 e 3 settimane prima dell'intervento con IPCL V2.0 sarà necessario praticare, mediante laser, piccoli fori sul bordo più esterno della parte colorata dell'occhio (iridotomia periferica);
- siete disposti a firmare un modulo di consenso informato prima della procedura.

Voi e il vostro medico determinerete se siete candidati idonei per la IPCL V2.0 (monofocale, torica, presbiopica e presbiopica torica) e la frequenza dei controlli necessari per monitorare la salute del vostro occhio.

Cosa aspettarsi durante l'intervento con IPCL V2.0?

Prima dell'intervento

Prima dell'intervento, il medico esaminerà la vostra storia clinica e oculare e controllerà entrambi gli occhi per assicurarsi che siano sani e idonei all'impianto della IPCL V2.0. Questo include la valutazione dello strato interno della cornea (endotelio).
Se utilizzate lenti a contatto, interrompetene l'uso da 2 a 4 settimane prima della visita oculistica e dellIntervento. Questo aiuta il medico a ottenere misurazioni accurate. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe influire sui risultati.

Informate il medico di tutti i farmaci che assumete, di eventuali problemi oculari, interventi chirurgici oculari precedenti, condizioni mediche o allergie. Chiedete se è consentito mangiare o bere prima dell'intervento. Inoltre, organizzatevi affinché qualcuno vi accompagni a casa, poiché non dovrete guidare subito dopo la procedura. Il medico vi indicherà quando sarà sicuro tornare a guidare.

Da due a tre settimane prima dell'intervento

Da due a tre settimane prima dell'intervento con IPCL V2.0, il medico eseguirà due piccoli fori sul bordo più esterno della parte colorata dell'occhio (iridotomie periferiche) per preparare l'occhio all'impianto della IPCL V2.0. Questa procedura è necessaria per garantire il corretto flusso del liquido dalla camera posteriore alla camera anteriore dell'occhio e prevenire un aumento della pressione intraoculare dopo l'intervento con IPCL V2.0.
Il medico applicherà generalmente colliri anestetici e realizzerà piccole aperture nella parte colorata dell'occhio (iride) utilizzando un raggio laser. Di norma questa procedura non influisce sulla capacità di guidare al ritorno a casa, ma è opportuno verificarlo con il proprio medico.
Dopo la procedura di iridotomia periferica vi verranno prescritti colliri da utilizzare. È importante seguire attentamente tutte le istruzioni relative ai farmaci. Il medico vi indicherà quando interrompere l'uso di questi medicinali prima del giorno dell'intervento.

Il giorno dell'intervento

Il giorno dell'intervento verranno instillati colliri nell'occhio per dilatare la pupilla (la parte nera dell'occhio). Una volta che la pupilla sarà completamente dilatata, il medico applicherà colliri anestetici e/o inietterà un anestetico nell'occhio e vi chiederà di sdraiarvi sulla schiena sul lettino o sulla poltrona operatoria nella sala di trattamento.
Prima dell'intervento, il medico potrebbe discutere con voi diverse opzioni per l'anestesia o il rilassamento. Verrà praticata una piccola incisione nella cornea (la parte anteriore trasparente dell'occhio) e la lente IPCL V2.0 verrà posizionata correttamente all'interno dell'occhio. La procedura dura generalmente da 20 a 30 minuti.

Dopo l'intervento, il medico applicherà colliri o un unguento oftalmico e potrà coprire l'occhio con una benda o uno schermo protettivo. La procedura è indolore grazie all'anestesia. Non guidate per tornare a casa dopo l'intervento. Organizzatevi in anticipo affinché qualcuno vi accompagni.

Il primo giorno dopo l'intervento

Il medico controllerà il vostro occhio il giorno successivo all'intervento, inclusa la misurazione della pressione intraoculare. Potreste avvertire sensibilità alla luce o la sensazione di avere qualcosa nell'occhio. Indossare occhiali da sole può essere utile. Un lieve fastidio o un leggero dolore sono normali e il medico potrebbe prescrivervi farmaci per alleviarli. In caso di dolore intenso, contattate immediatamente il medico.
Dovrete utilizzare colliri o unguenti oftalmici per circa una settimana per prevenire le infezioni e ridurre l'infiammazione.

IMPORTANTE: utilizzate i farmaci oculari esattamente come indicato dal vostro oculista. (I risultati possono dipendere dal rispetto delle istruzioni fornite dal medico).

NON strofinate gli occhi, soprattutto durante i primi 3-5 giorni dopo l'intervento. Se notate un improvviso peggioramento della vista, contattate immediatamente il vostro medico.

Assistenza a lungo termine:

in alcuni casi, la IPCL V2.0 potrebbe dover essere sostituita o rimossa. Può essere sostituita se un'altra lente risulta più adatta al vostro occhio o può offrirvi una visione migliore. Può essere rimossa qualora sviluppiate una cataratta e sia necessario un intervento di cataratta. In tali casi, può essere impiantata una nuova lente per contribuire a correggere la vista.

Se la IPCL V2.0 viene rimossa, perderete la correzione visiva che forniva e la vostra vista potrebbe non essere più la stessa di prima dell'intervento. È importante seguire le indicazioni del medico e partecipare a tutte le visite di controllo dopo l'intervento.
Domande da porre al medico
Potreste voler porre le seguenti domande per aiutarvi a decidere se l'intervento con IPCL V2.0 per la correzione della miopia o

dell'ipermetropia è adatto a voi:

- Quali altre opzioni ho per correggere la mia miopia o ipermetropia?
- Dovrò limitare le mie attività dopo l'intervento e per quanto tempo?
- Quali sono i benefici dell'intervento con IPCL V2.0 per il mio grado di miopia o ipermetropia?
- Come sarà la mia vista nei primi mesi dopo l'intervento?
- Se l'intervento con IPCL V2.0 non correggesse completamente la mia vista, quale sarebbe la probabilità di aver bisogno di occhiali più forti rispetto a prima? Il mio bisogno di occhiali potrebbe aumentare nel tempo? Potrei sottopormi a un altro tipo di chirurgia oculare per correggere la vista?
- In che modo l'intervento con IPCL V2.0 potrebbe influenzare la necessità di portare occhiali o lenti a contatto con l'avanzare dell'età?
- Il mio occhio guarirà in modo diverso in caso di lesione dopo l'impianto della IPCL V2.0?
- Dovrei sottopormi all'intervento con IPCL V2.0 anche nell'altro occhio?
- Quanto tempo dovrò attendere prima di poter operare anche l'altro occhio?
- Quali problemi visivi potrei riscontrare se la IPCL V2.0 venisse impiantata in un solo occhio?

Riepilogo delle Informazioni Importanti

- L'intervento con IPCL V2.0 fornisce una correzione permanente della miopia o dell'ipermetropia finché la IPCL V2.0 rimane nell'occhio. La IPCL V2.0 può essere rimossa. Se viene rimossa, perderete questo beneficio e la vostra vista potrebbe non essere più la stessa di prima dell'intervento.
- L'intervento con IPCL V2.0 non elimina la necessità di utilizzare occhiali da lettura, anche se non ne avete mai avuti bisogno in precedenza.
- La vostra vista deve essere stabile prima dell'intervento con IPCL V2.0. Dovete fornire una documentazione scritta che dimostri che la vostra miopia o ipermetropia non è cambiata di oltre 0,50 D all'anno per almeno 1 anno.
- Se siete in gravidanza o state allattando, dovreste attendere prima di sottoporvi a questo intervento.
- Come tutti gli interventi chirurgici, anche la IPCL V2.0 comporta dei rischi. È importante leggere e comprendere tutte le informazioni prima di prendere una decisione.
- Altre opzioni per correggere la vista includono occhiali, lenti a contatto e interventi chirurgici come RK, PRK e LASIK.
- Prima di prendere in considerazione l'intervento con IPCL V2.0 dovreste:
  a. sottoporvi a un esame oculistico completo.
  b. discutere con almeno un professionista della cura degli occhi riguardo all'intervento con IPCL V2.0, in particolare dei potenziali benefici, rischi e complicanze. Dovreste inoltre discutere del tempo necessario per la guarigione dopo l'intervento.

Compatibilità con la Risonanza Magnetica

La IOL impiantata non contiene componenti metallici ed è sicura, senza alcun potenziale di interazione con il campo di Risonanza Magnetica (RM). La IOL è sicura per l'esecuzione di esami di Risonanza Magnetica per Immagini (MRI) con intensità del campo magnetico di 1,5 Tesla e 3,0 Tesla.

Durata prevista e follow-up necessari

La IOL generalmente dura per tutta la vita del paziente. Tuttavia, qualora doveste riscontrare un peggioramento della qualità della vista, consultate il vostro oculista per ulteriori accertamenti e trattamenti. Il vostro oculista discuterà con voi la frequenza dei controlli necessari in base alle vostre condizioni cliniche.

Segnalazione di incidenti gravi

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione alla lente intraoculare deve essere segnalato al proprio medico (in prima istanza), al rappresentante locale o a EYEOL U.K. LIMITED.

Informazioni su questo documento

Il vostro oculista ha eseguito l'intervento chirurgico refrattivo e ha impiantato la lente intraoculare (IOL) nel vostro occhio. La scheda impianto del paziente e questo foglio informativo vi sono stati consegnati dopo l'intervento. Vi invitiamo a portare sempre con voi la scheda impianto del paziente per facilitare l'assistenza medica in caso di emergenza. Il collegamento riportato sulla scheda impianto vi fornirà gli aggiornamenti più recenti relativi alla IOL.

MFG/MD/2020/000163
EYEOL U.K. LIMITED
8 Apex Business Centre, Boscombe Road,
Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, Regno Unito
Tel: +44 (0) 1582 477 002
Fax: +44 (0) 1582 607 009
Email: info@eyeol.co.uk
Web: www.eyeol.co.uk

EU REP **Rappresentante Europeo**
OBELIS S.A
Bd. Général Wahis, 53
1030 Bruxelles, Belgio
Tel: +32.2.732.59.54
Fax: +32.2.732.60.03
Email: mail@obelis.net
Web: www.obelis.net

CE
2460

PT

- Encandeamento significativo e/ou halos em redor das luzes
- Descentração/rotação da IPCL V2.0
- Perda de células endoteliais da córnea
- Luxação/rotação da lente IPCL V2.0
- Perda da melhor acuidade visual corrigida com óculos
- Intervenção cirúrgica secundária para remover/substituir a IPCL V2.0
- A implantação de uma IPCL V2.0 pode resultar numa diminuição da densidade das células endoteliais da córnea.

Contraindicações e advertências

- A Lente de Contacto Fácica Implantável (IPCL V2.0) está contraindicada na presença de qualquer uma das seguintes circunstâncias e/ou condições, incluindo, mas não se limitando a: pacientes com antecedentes e/ou sinais clínicos de irite, uveíte, sinéquias, síndrome de dispersão pigmentar, doença da retina (exceto manifestações de degeneração miópica), inflamação intraocular crónica, degenerescência macular, astigmatismo irregular, ceratocone ou edema macular cistoide em qualquer dos olhos.
- Pacientes com retinopatia diabética em qualquer dos olhos.
- Pacientes com glaucoma em qualquer dos olhos.
- Pacientes com antecedentes de cirurgia intraocular prévia (incluindo cirurgia refrativa) no olho a tratar.
- Pacientes com ambliopia ou cegueira no olho contralateral.
- Pacientes que não se enquadrem nos intervalos de miopia e/ou astigmatismo pré-tratamento definidos nos critérios de inclusão deste protocolo clínico.
- Pacientes com doença progressiva que ameace a visão. São permitidos pacientes com achados retinianos associados à miopia patológica.
- Pacientes com diagnóstico de hipertensão ocular.
- Pacientes com diabetes dependente de insulina.
- Pacientes com distrofia de Fuchs ou outra patologia da córnea.
- Pacientes com catarata em qualquer dos olhos.
- Pacientes com refração instável nos últimos 12 meses (miopia e/ou astigmatismo).
- Pacientes grávidas ou a amamentar.
- Pacientes com baixa densidade ou densidade anormal de células endoteliais da córnea.
- Pacientes com profundidade da câmara anterior < 2,8 mm.

É um bom candidato para a cirurgia com IPCL V2.0?

O seu médico realizará um exame oftalmológico detalhado para determinar se a cirurgia com IPCL V2.0 é adequada para si. Poderá ser considerado candidato para esta cirurgia se:

- tiver entre 21 e 45 anos de idade (para lentes Monofocais e Tóricas) ou entre 40 e 60 anos de idade (para lentes para presbiopia);
- apresentar miopia entre –0,5 D e –15 D ou hipermetropia entre +0,5 D e +15 D (para IPCL V2.0 Monofocal e IPCL V2.0 Tórica) e astigmatismo entre +1,0 D e +10 D (para IPCL V2.0 para Presbiopia e IPCL V2.0 Tórica para Presbiopia);
- tiver astigmatismo (para lentes tóricas), se aplicável;
- possuir espaço suficiente no interior do olho para colocar a lente de forma segura;
- apresentar uma densidade minimamente aceitável da fina camada única de células (células endoteliais) localizada na superfície mais interna da córnea, responsável por manter a córnea transparente. Se o seu médico determinar que a densidade das suas células endoteliais está abaixo do nível mínimo, terá um risco acrescido de inchaço da córnea (edema corneano), podendo ser necessária a remoção e substituição da córnea (transplante de córnea);
- possuir evidência escrita de que a sua miopia ou hipermetropia se manteve estável durante pelo menos 1 ano;
- compreender os benefícios e os riscos da cirurgia em comparação com outras opções de tratamento;
- não ter alergias conhecidas a quaisquer medicamentos que o seu médico possa indicar para utilização antes, durante e após a cirurgia;
- não estar grávida nem a amamentar;
- compreender que, entre 2 a 3 semanas antes da cirurgia com IPCL V2.0, será necessário criar pequenas aberturas na extremidade periférica da parte colorida do olho (iridotomia periférica) utilizando um laser;
- estar disposto(a) a assinar um formulário de consentimento antes do procedimento.

O seu médico e você determinarão se é um candidato adequado para a IPCL V2.0 (monofocal, tórica, para presbiopia e tórica para presbiopia) e a frequência do acompanhamento necessária para monitorizar a saúde dos seus olhos.

O que deve esperar durante a cirurgia com IPCL V2.0?

Antes da cirurgia

Antes da cirurgia, o seu médico analisará o seu historial médico e oftalmológico e examinará ambos os olhos para garantir que estão saudáveis e adequados para a IPCL V2.0. Isto inclui a avaliação da camada interna da córnea (endotélio). Se utilizar lentes de contacto, deverá interromper a sua utilização 2 a 4 semanas antes do exame oftalmológico e da cirurgia. Isto ajuda o médico a obter medições precisas. O não cumprimento desta recomendação poderá afetar os seus resultados.

Informe o seu médico sobre quaisquer medicamentos que esteja a tomar, problemas oculares, cirurgias oculares anteriores, condições médicas ou alergias. Pergunte se deve comer ou beber antes da cirurgia. Além disso, providencie alguém para o levar para casa, uma vez que não deverá conduzir imediatamente após o procedimento. O seu médico informá-lo-á quando será seguro voltar a conduzir.

Duas a três semanas antes da cirurgia

Duas a três semanas antes da cirurgia com IPCL V2.0, o seu médico realizará duas pequenas aberturas na extremidade periférica da parte colorida do olho (iridotomias periféricas) para preparar o seu olho para a implantação da IPCL V2.0. Este procedimento é necessário para assegurar que o fluido circula corretamente da câmara posterior para a câmara anterior do olho, evitando um aumento da pressão intraocular após a cirurgia com IPCL V2.0. O médico aplicará normalmente gotas anestésicas no olho e fará pequenas aberturas na íris utilizando um feixe laser. Geralmente, este procedimento não afeta a sua capacidade de conduzir para casa, mas deverá confirmar essa informação com o seu médico.
Após o procedimento de iridotomia periférica, ser-lhe-ão prescritas gotas oftálmicas para utilização. É importante seguir todas as instruções relativas à medicação. O seu médico indicar-lhe-á quando deverá interromper a utilização destes medicamentos antes do dia da cirurgia.

O dia da cirurgia

No dia da cirurgia, serão aplicadas gotas oftálmicas para dilatar a pupila. Quando a pupila estiver totalmente dilatada, o seu médico aplicará gotas anestésicas no olho e/ou administrará uma injeção com anestésico ocular e pedir-lhe-á que se deite de costas na marquesa/cadeira de tratamento na sala de procedimentos. O seu médico poderá discutir consigo diferentes opções para anestesia ou relaxamento antes da cirurgia.
Será efetuada uma pequena incisão na córnea (a parte transparente da frente do olho) e a lente IPCL V2.0 será colocada na posição correta dentro do olho. O procedimento demora normalmente entre 20 e 30 minutos.

Após a cirurgia, o seu médico aplicará gotas oftálmicas ou pomada e poderá cobrir o olho com um penso ou escudo protetor. O procedimento é indolor devido à anestesia utilizada. Não conduza para casa após a cirurgia. Por favor, organize antecipadamente alguém para o acompanhar e levar para casa.

O primeiro dia após a cirurgia

O seu médico irá examinar o seu olho no dia seguinte à cirurgia, incluindo a medição da pressão intraocular. Poderá sentir sensibilidade à luz ou a sensação de que existe algo dentro do olho. O uso de óculos de sol pode ajudar. Algum desconforto ou dor ligeira é normal, e o seu médico poderá prescrever medicação para ajudar. Se sentir dor intensa, contacte imediatamente o seu médico. Terá de utilizar gotas oftálmicas ou pomada durante cerca de uma semana para prevenir infeções e reduzir a inflamação.

IMPORTANTE: Utilize os medicamentos oftálmicos exatamente conforme indicado pelo seu oftalmologista. (Os seus resultados poderão depender do cumprimento das instruções do seu médico).

NÃO esfregue os olhos, especialmente durante os primeiros 3 a 5 dias após a cirurgia. Se notar qualquer diminuição súbita da visão, deverá contactar imediatamente o seu médico.

Cuidados a longo prazo:

Em alguns casos, a IPCL V2.0 poderá necessitar de ser substituída ou removida. Poderá ser substituída se outra lente for mais adequada para o seu olho ou proporcionar melhor visão. Poderá ser removida se desenvolver uma catarata e necessitar de cirurgia de catarata. Nesses casos, poderá ser implantada uma nova lente para ajudar a corrigir a sua visão.

Se a IPCL V2.0 for removida, perderá a correção visual que esta proporcionava e a sua visão poderá não ser igual à que tinha antes da cirurgia. É importante seguir os conselhos do seu médico e comparecer a todas as consultas de acompanhamento após a cirurgia.
Perguntas a colocar ao seu médico
Poderá querer fazer as seguintes perguntas para o ajudar a decidir se a cirurgia com IPCL V2.0 para corrigir a miopia ou a

hipermetropia é adequada para si:

- Que outras opções tenho para corrigir a minha miopia ou hipermetropia?
- Terei de limitar as minhas atividades após a cirurgia e durante quanto tempo?
- Quais são os benefícios da cirurgia com IPCL V2.0 para o meu grau de miopia ou hipermetropia?
- Como será a minha visão nos primeiros meses após a cirurgia?
- Se a cirurgia com IPCL V2.0 não corrigir a minha visão, qual é a probabilidade de eu precisar de óculos com uma graduação mais elevada do que antes? A minha necessidade de usar óculos poderá aumentar com o tempo? Poderia submeter-me a outro tipo de cirurgia ocular para corrigir a minha visão?
- De que forma a cirurgia com IPCL V2.0 poderá afetar a minha necessidade de usar óculos ou lentes de contacto à medida que envelheço?
- O meu olho cicatrizará de forma diferente se sofrer uma lesão após a implantação da IPCL V2.0?
- Deverei realizar a cirurgia com IPCL V2.0 também no outro olho?
- Quanto tempo terei de esperar antes de poder realizar a cirurgia no outro olho?
- Que problemas visuais poderei sentir se tiver a IPCL V2.0 implantada apenas num olho?

Resumo das Informações Importantes

- A cirurgia IPCL V2.0 proporciona uma correção permanente da sua miopia ou hipermetropia enquanto a IPCL V2.0 permanecer no olho. A IPCL V2.0 pode ser removida. Se for removida, perderá este benefício e a sua visão poderá não ser a mesma que tinha antes da cirurgia.
- A cirurgia IPCL V2.0 não elimina a necessidade de usar óculos para leitura, mesmo que nunca os tenha utilizado anteriormente.
- A sua visão deve estar estável antes da cirurgia IPCL V2.0. Deve fornecer evidência escrita de que a sua miopia ou hipermetropia não se alterou mais de 0,50 D por ano durante, pelo menos, 1 ano.
- Se estiver grávida ou a amamentar, deverá adiar esta cirurgia.
- Como todas as cirurgias, a IPCL V2.0 apresenta riscos. É importante ler e compreender todas as informações antes de tomar uma decisão.
- Outras opções para corrigir a sua visão incluem óculos, lentes de contacto e cirurgias como RK, PRK e LASIK.
- Antes de considerar a cirurgia IPCL V2.0, deverá:
  a. realizar um exame oftalmológico completo.
  b. conversar com, pelo menos, um profissional de saúde ocular sobre a cirurgia IPCL V2.0, especialmente sobre os potenciais benefícios, riscos e complicações. Deverá também discutir o tempo necessário para a recuperação após a cirurgia.

Compatibilidade com Ressonância Magnética:

A LIO implantada não contém quaisquer componentes metálicos e é segura, não apresentando potencial de interação com o campo de Ressonância Magnética (RM). A LIO é segura para exames de Imagiologia por Ressonância Magnética (IRM) com intensidades de campo magnético de 1,5 e 3,0 Tesla.

Vida útil prevista e acompanhamento necessário

A LIO normalmente durará toda a vida do paciente. No entanto, caso observe qualquer deterioração da qualidade da sua visão, consulte o seu oftalmologista para investigação e tratamento adicionais. O seu oftalmologista discutirá consigo os intervalos de acompanhamento necessários com base na sua condição médica.

Notificação de incidentes graves

Qualquer incidente grave relacionado com a lente intraocular deverá ser comunicado ao seu médico (em primeira instância), ao representante local ou à EYEOL U.K. LIMITED.

Sobre este documento:

O seu oftalmologista realizou a cirurgia refrativa e implantou a lente intraocular (LIO) no seu olho. O cartão de implante do paciente e este folheto foram-lhe entregues após a cirurgia. Por favor, transporte sempre consigo o cartão de implante do paciente para facilitar os cuidados médicos em caso de emergência. A ligação fornecida no cartão de implante disponibilizará as atualizações mais recentes sobre a LIO.

MFG/MD/2020/000163
EYEOL U.K. LIMITED
8 Apex Business Centre, Boscombe Road,
Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, Reino Unido
Tel: +44 (0) 1582 477 002
Fax: +44 (0) 1582 607 009
Email: info@eyeol.co.uk
Web: www.eyeol.co.uk

EU REP **Representante Europeu**
OBELIS S.A
Bd. General Wahis, 53
1030 Bruxelas, Bélgica
Tel: +32.2.732.59.54
Fax: +32.2.732.60.03
Email: mail@obelis.net
Web: www.obelis.net

CE
2460

ES

- Deslumbramiento significativo y/o halos alrededor de las luces
- Descentración/rotación de la IPCL V2.0
- Pérdida de células endoteliales corneales
- Luxación/rotación de la IPCL V2.0
- Pérdida de la mejor agudeza visual corregida con gafas
- Intervención quirúrgica secundaria para retirar o reemplazar la IPCL V2.0
- La implantación de una IPCL V2.0 puede provocar una disminución de la densidad de células endoteliales corneales.
-

Contraindicaciones y advertencias

- La Lente de Contacto Fáquica Implantable (IPCL V2.0) está contraindicada en presencia de cualquiera de las siguientes circunstancias y/o condiciones, incluidas, entre otras: pacientes con antecedentes y/o signos clínicos de iritis, uveítis, sinequias, síndrome de dispersión pigmentaria, enfermedad retiniana (excepto manifestaciones de degeneración miópica), inflamación intraocular crónica, degeneración macular, astigmatismo irregular, queratocono o edema macular quístico en cualquiera de los ojos.
- Pacientes con retinopatía diabética en cualquiera de los ojos.
- Pacientes con glaucoma en cualquiera de los ojos.
- Pacientes con antecedentes de cirugía intraocular previa (incluida cirugía refractiva) en el ojo que va a ser tratado.
- Pacientes con ambliopía o ceguera en el ojo contralateral.
- Pacientes que no se encuentren dentro del rango de miopía y/o astigmatismo previo al tratamiento descrito en los criterios de inclusión de este protocolo clínico.
- Pacientes con una enfermedad progresiva que amenace la visión. Se permiten pacientes con hallazgos retinianos asociados a miopía patológica.
- Pacientes con diagnóstico de hipertensión ocular.
- Pacientes con diabetes insulinodependiente.
- Pacientes con distrofia de Fuchs u otra patología corneal.
- Pacientes con cataratas en cualquiera de los ojos.
- Pacientes con una refracción inestable durante los últimos 12 meses (miopía y/o astigmatismo).
- Pacientes embarazadas o en período de lactancia.
- Pacientes con una densidad de células endoteliales corneales baja o anormal.
- Pacientes con una profundidad de cámara anterior < 2,8 mm.

¿Es usted un buen candidato para la cirugía IPCL V2.0?

Su médico realizará una evaluación oftalmológica detallada para determinar si la cirugía IPCL V2.0 es adecuada para usted. Puede ser considerado candidato para esta cirugía si:

- tiene entre 21 y 45 años (para lentes monofocales y tóricas) o entre 40 y 60 años (para lentes para presbicia).
- presenta miopía entre –0,5 D y –15 D o hipermetropía entre +0,5 D y +15 D (para IPCL V2.0 Monofocal e IPCL V2.0 Tórica) y astigmatismo entre +1,0 D y +10 D (para IPCL V2.0 para Presbicia e IPCL V2.0 Tórica para Presbicia).
- presenta astigmatismo (para lentes tóricas), cuando corresponda.
- dispone de suficiente espacio dentro del ojo para colocar la lente de forma segura.
- tiene una densidad mínimamente aceptable de la fina capa única de células (células endoteliales) situada en la superficie más interna de la córnea, responsable de mantener la córnea transparente. Si su médico determina que su densidad de células endoteliales está por debajo del nivel mínimo, tendrá un mayor riesgo de desarrollar hinchazón corneal (edema corneal), lo que podría requerir la extracción y sustitución de la córnea (trasplante de córnea).
- dispone de evidencia escrita que demuestre que su miopía o hipermetropía ha permanecido estable durante al menos 1 año.
- comprende los beneficios y los riesgos de la cirugía en comparación con otras opciones de tratamiento.
- no tiene alergias conocidas a ninguno de los medicamentos que su médico pueda utilizar antes, durante o después de la cirugía.
- no está embarazada ni en período de lactancia.
- comprende que entre 2 y 3 semanas antes de la cirugía IPCL V2.0 será necesario realizar pequeños orificios en el borde más externo de la parte coloreada del ojo (iridotomía periférica) mediante láser.
- está dispuesto a firmar un formulario de consentimiento antes del procedimiento.

Usted y su médico determinarán si es un candidato adecuado para la IPCL V2.0 (monofocal, tórica, para presbicia y tórica para presbicia), así como la frecuencia de seguimiento necesaria para controlar la salud de su ojo.

¿Qué debe esperar durante la cirugía IPCL V2.0?

Antes de la cirugía

Antes de la cirugía, su médico revisará su historial médico y oftalmológico y examinará ambos ojos para asegurarse de que estén sanos y sean adecuados para la implantación de la IPCL V2.0. Esto incluye la evaluación de la capa interna de la córnea (endotelio). Si usa lentes de contacto, deje de utilizarlos entre 2 y 4 semanas antes de la revisión oftalmológica y de la cirugía. Esto ayuda a su médico a obtener mediciones precisas. No hacerlo puede afectar sus resultados.

Informe a su médico sobre cualquier medicamento que esté tomando, problemas oculares, cirugías oculares previas, afecciones médicas o alergias. Pregunte si debe comer o beber antes de la cirugía. Asimismo, organice con antelación que alguien lo lleve a casa, ya que no debe conducir inmediatamente después del procedimiento. Su médico le indicará cuándo podrá volver a conducir de forma segura.

Dos a tres semanas antes de la cirugía

Entre dos y tres semanas antes de la cirugía IPCL V2.0, su médico realizará dos pequeños orificios en el borde más externo de la parte coloreada del ojo (iridotomías periféricas) para preparar el ojo para la implantación de la IPCL V2.0. Esto es necesario para asegurar que el líquido fluya correctamente desde la cámara posterior hacia la cámara anterior del ojo y evitar un aumento de la presión intraocular después de la cirugía IPCL V2.0. Normalmente, el médico aplicará gotas anestésicas y realizará pequeñas aberturas en la parte coloreada del ojo (iris) utilizando un láser. Por lo general, este procedimiento no afecta su capacidad para conducir de regreso a casa, pero debe confirmarlo con su médico.
Después del procedimiento de iridotomía periférica, se le recetarán gotas oftálmicas para su uso. Es importante que siga todas las instrucciones relacionadas con la medicación. Su médico le indicará cuándo debe suspender el uso de estos medicamentos antes del día de la cirugía.

El día de la cirugía

El día de la cirugía, se aplicarán gotas en sus ojos para dilatar la pupila (la parte negra del ojo). Una vez que la pupila esté completamente dilatada, su médico le administrará gotas anestésicas y/o una inyección con medicación anestésica en el ojo, y le pedirá que se acueste boca arriba en la mesa o silla de tratamiento de la sala de procedimientos. Su médico puede comentarle diferentes opciones para anestesiarle o ayudarle a relajarse antes de la cirugía.
Se realizará una pequeña incisión en la córnea (la parte frontal transparente del ojo) y se colocará la lente IPCL V2.0 en la posición correcta dentro del ojo. El procedimiento suele durar entre 20 y 30 minutos.

Después de la cirugía, su médico aplicará gotas oftálmicas o una pomada y podrá cubrir el ojo con un parche o protector para su protección. Gracias a la anestesia, el procedimiento es indoloro. No conduzca usted mismo después de la cirugía. Organice con antelación que alguien lo lleve a casa.

El primer día después de la cirugía

Su médico revisará su ojo al día siguiente de la cirugía, incluida la medición de la presión intraocular. Puede experimentar sensibilidad a la luz o la sensación de tener algo dentro del ojo. El uso de gafas de sol puede ayudar. Es normal sentir cierta molestia o dolor leve, y su médico puede recetarle medicamentos para aliviarlo. Si experimenta dolor intenso, contacte inmediatamente con su médico. Necesitará utilizar gotas oftálmicas o pomada durante aproximadamente una semana para prevenir infecciones y reducir la inflamación.

IMPORTANTE: Utilice los medicamentos oftálmicos exactamente según las indicaciones de su oftalmólogo. (Sus resultados pueden depender de que siga las instrucciones de su médico).

NO se frote los ojos, especialmente durante los primeros 3 a 5 días después de la cirugía. Si nota una disminución repentina de la visión, debe ponerse en contacto con su médico inmediatamente.

Cuidados a largo plazo:

En algunos casos, la IPCL V2.0 puede necesitar ser sustituida o retirada. Puede sustituirse si otra lente es más adecuada para su ojo o puede proporcionarle una mejor visión. Puede retirarse si desarrolla una catarata y necesita cirugía de cataratas. En tales casos, puede implantarse una nueva lente para ayudar a corregir su visión.

Si se retira la IPCL V2.0, perderá la corrección visual que proporcionaba y su visión puede no ser la misma que antes de la cirugía. Es importante seguir las recomendaciones de su médico y acudir a todas las visitas de seguimiento después de la cirugía.
Preguntas para hacer a su médico
Puede que desee hacer las siguientes preguntas para ayudarle a decidir si la cirugía IPCL V2.0 para corregir la miopía o la

hipermetropía es adecuada para usted

- **:**¿Qué otras opciones tengo para corregir mi miopía o hipermetropía?
- ¿Tendré que limitar mis actividades después de la cirugía y durante cuánto tiempo?
- ¿Cuáles son los beneficios de la cirugía IPCL V2.0 para mi grado de miopía o hipermetropía?
- ¿Cómo será mi visión durante los primeros meses después de la cirugía?
- Si la cirugía IPCL V2.0 no corrige mi visión, ¿qué posibilidad existe de que mis gafas necesiten una graduación mayor que antes? ¿Podría aumentar mi necesidad de usar gafas con el tiempo? ¿Podría someterme a otro tipo de cirugía ocular para corregir mi visión?
- ¿Cómo es probable que la cirugía IPCL V2.0 afecte mi necesidad de usar gafas o lentes de contacto a medida que envejezca?
- ¿Sanará mi ojo de manera diferente si sufre una lesión después de la implantación de la IPCL V2.0?
- ¿Debería someterme a la cirugía IPCL V2.0 también en el otro ojo?
- ¿Cuánto tiempo tendré que esperar antes de poder operarme el otro ojo?
- ¿Qué problemas visuales podría experimentar si me implanto la IPCL V2.0 solo en un ojo?

Resumen de información importante

- La cirugía IPCL V2.0 proporciona una corrección permanente de su miopía o hipermetropía mientras la IPCL V2.0 permanezca en el ojo. La IPCL V2.0 puede retirarse. Si se retira, perderá este beneficio y su visión puede no ser la misma que antes de la cirugía.
- La cirugía IPCL V2.0 no elimina la necesidad de usar gafas para leer, incluso si nunca las ha necesitado anteriormente.
- Su visión debe ser estable antes de la cirugía IPCL V2.0. Debe proporcionar evidencia escrita de que su miopía o hipermetropía no ha cambiado más de 0,50 D por año durante al menos 1 año.
- Si está embarazada o en período de lactancia, debe esperar antes de someterse a esta cirugía.
- Como todas las cirugías, la IPCL V2.0 conlleva riesgos. Es importante leer y comprender toda la información antes de tomar una decisión.
- Otras opciones para corregir su visión incluyen gafas, lentes de contacto y cirugías como RK, PRK y LASIK.
- Antes de considerar la cirugía IPCL V2.0, usted debe:
  a. someterse a un examen oftalmológico completo.
  b. hablar con al menos un profesional de la salud visual acerca de la cirugía IPCL V2.0, especialmente sobre los posibles beneficios, riesgos y complicaciones. También debe hablar sobre el tiempo necesario para la recuperación después de la cirugía.

Compatibilidad con Resonancia Magnética:

La LIO implantada no contiene componentes metálicos y es segura, sin potencial de interacción con el campo de Resonancia Magnética (RM). La LIO es segura para la obtención de imágenes por Resonancia Magnética (IRM) con intensidades de campo magnético de 1,5 y 3,0 Tesla.

Vida útil esperada y seguimiento necesario

La LIO normalmente durará toda la vida del paciente. No obstante, si experimenta cualquier deterioro en la calidad de su visión, consulte a su oftalmólogo para una evaluación y tratamiento adicionales. Su oftalmólogo le indicará los intervalos de seguimiento necesarios en función de su estado de salud.

Notificación de incidentes graves

Cualquier incidente grave que ocurra en relación con la lente intraocular deberá notificarse a su médico (en primera instancia), al representante local o a EYEOL U.K. LIMITED.

Acerca de este documento:

Su oftalmólogo ha realizado la cirugía refractiva e implantado la lente intraocular (LIO) en su ojo. Después de la cirugía, se le ha entregado la tarjeta de implante del paciente y este folleto. Lleve siempre consigo la tarjeta de implante del paciente para facilitar la atención médica en caso de emergencia. El enlace proporcionado en la tarjeta de implante le permitirá acceder a las actualizaciones más recientes sobre la LIO.

MFG/MD/2020/000163
EYEOL U.K. LIMITED
8 Apex Business Centre, Boscombe Road,
Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, Reino Unido
Tel: +44 (0) 1582 477 002
Fax: +44 (0) 1582 607 009
Correo electrónico: info@eyeol.co.uk
Sitio web: www.eyeol.co.uk

EU REP **Representante europeo**
OBELIS S.A
Bd. General Wahis, 53
1030 Bruselas, Bélgica
Tel: +32.2.732.59.54
Fax: +32.2.732.60.03
Correo electrónico: mail@obelis.net
Sitio web: www.obelis.net

CE
2460